ACADEMIA EXAMEN EUNACOM

1ª EDICIÓN · 2026

Libro Gordo

GASTROENTEROLOGÍA

90 preguntas de práctica

Hepatología

MATRIZ PERFIL V3 · DISTRIBUCIÓN POR BLOQUES

Gastroenterología · Secuencia Cardinal de Estudio (Bloque 1 a 5)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
BLOQUE 1: ESÓFAGO Y ESTÓMAGO					
1.06.1.002	Cáncer de páncreas	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q1	Tomo 03 · C.2 (Pág. 8)
1.06.1.004	Cáncer gástrico	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q2, Q17, Q18	Tomo 03 · 1.5 (Pág. 13)
1.06.1.011	Diarrea crónica	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q3	Tomo 03 · C.10 (Pág. 24)
1.06.1.013	Disfagia	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q4, Q13, Q14	Tomo 03 · 1.3 (Pág. 9)
1.06.1.016	Enfermedad diverticular complicada	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q5	Tomo 03 · Gastroenterología (Pág. 8)
1.06.1.027	Reflujo gastroesofágico	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	—	Q6, Q9, Q10	Tomo 03 · 1.1 (Pág. 5)
1.06.1.030	Úlcera péptica	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	—	Q7, Q11, Q12	Tomo 03 · 1.2 (Pág. 7)
1.06.2.002	Afagia aguda	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q8, Q15, Q16	Tomo 03 · 1.4 (Pág. 11)
BLOQUE 2: INTESTINO Y COLON					
1.06.1.008	Trastornos digestivos funcionales	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	—	Q19, Q29, Q30	Tomo 03 · 2.1 (Pág. 20)
1.06.1.012	Diarrea en inmunosuprimidos	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q20	Tomo 03 · Gastroenterología (Pág. 8)
1.06.1.015	Enfermedad celiaca	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	—	Q21, Q33, Q34	Tomo 03 · 2.3 (Pág. 24)
1.06.1.017	Enfermedad diverticular no complicada	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	—	Q22	Tomo 03 · Gastroenterología (Pág. 8)
1.06.1.018	Enfermedad inflamatoria intestinal	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q23, Q35, Q36	Tomo 03 · 2.4 (Pág. 26)
1.06.1.023	Intolerancia a la lactosa	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	—	Q24	Tomo 03 · Gastroenterología (Pág. 8)
1.06.1.026	Parasitosis intestinales	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	—	Q25	Tomo 03 · Gastroenterología (Pág. 8)
1.06.1.028	Síndrome de malabsorción	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q26	Tomo 03 · Gastroenterología (Pág. 8)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
1.06.1.029	Tumores de colon	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q27	Tomo 03 · 2.5 (Pág. 28)
1.06.2.005	Diarrea aguda	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	—	Q28, Q31, Q32	Tomo 03 · 2.2 (Pág. 22)
BLOQUE 3: HÍGADO					
1.06.1.001	Ascitis	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q37	Tomo 03 · C.4 (Pág. 12)
1.06.1.005	Daño Hepático Crónico e Hipertensión Portal	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q54	Tomo 03 · 3.3 (Pág. 39)
1.06.1.007	Colestasia	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q38, Q49, Q50	Tomo 03 · 3.1 (Pág. 35)
1.06.1.019	Hepatitis aguda A no complicada	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	—	Q39, Q51, Q52, Q53	Tomo 03 · 3.2 (Pág. 37)
1.06.1.020	Hepatitis agudas B, C, por otros virus, por drogas y tóxicas	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q40	Tomo 03 · Gastroenterología (Pág. 8)
1.06.1.021	Hepatitis crónica	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q41	Tomo 03 · Gastroenterología (Pág. 8)
1.06.1.022	Insuficiencia hepática crónica	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q42	Tomo 03 · Gastroenterología (Pág. 8)
1.06.1.024	Masa hepática	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q43	Tomo 03 · 3.4 (Pág. 41)
1.06.2.006	Encefalopatía hepática	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q44	Tomo 03 · Gastroenterología (Pág. 8)
1.06.2.008	Hepatitis aguda A complicada	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q45	Tomo 03 · Gastroenterología (Pág. 8)
1.06.2.009	Insuficiencia hepática aguda	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q46	Tomo 03 · Gastroenterología (Pág. 8)
1.06.2.011	Peritonitis bacteriana espontánea del cirrótico	Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar**	—	Q47	Tomo 03 · Gastroenterología (Pág. 8)
1.06.2.012	Síndrome hepatorrenal	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q48	Tomo 03 · Gastroenterología (Pág. 8)
BLOQUE 4: VÍA BILIAR Y PÁNCREAS					
1.06.1.003	Cáncer de vesícula y vías biliares	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q55, Q56, Q57	Tomo 03 · C.3 (Pág. 10)
1.06.1.006	Colelitiasis	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q58, Q59, Q60, Q61, Q62, Q63, Q69, Q70	Tomo 03 · 4.1 (Pág. 46)
1.06.1.010	Diarrea asociada a antibióticos	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	—	Q64	Tomo 03 · C.9 (Pág. 22)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
1.06.1.025	Pancreatitis crónica	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q65	Tomo 03 · Gastroenterología (Pág. 8)
1.06.2.003	Colangitis	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q66	Tomo 03 · Gastroenterología (Pág. 8)
1.06.2.004	Colecistitis aguda	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q67	Tomo 03 · Gastroenterología (Pág. 8)
1.06.2.010	Pancreatitis aguda	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q68, Q71, Q72	Tomo 03 · 4.2 (Pág. 48)
BLOQUE 5: ABDOMEN AGUDO Y URGENCIAS DIGESTIVAS					
1.01.1.001	Cirugía Pediátrica Digestiva: Urgencias y Malformaciones	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q89, Q90	Tomo 01 · 2.2 (Pág. 30)
1.06.1.009	Constipación	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	—	Q73	Tomo 03 · C.8 (Pág. 20)
1.06.1.014	Dispepsia	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	—	Q74	Tomo 03 · Gastroenterología (Pág. 8)
1.06.1.027	Reflujo del Lactante, Dolor Abdominal Crónico y Constipación en el Niño	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q87, Q88	Tomo 03 · 1.1 (Pág. 5)
1.06.2.001	Abdomen agudo	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q75, Q77, Q78, Q79, Q80	Tomo 03 · 5.1 (Pág. 53)
1.06.2.002	Cuerpo Extraño Digestivo	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q83, Q84	Tomo 03 · 1.4 (Pág. 11)
1.06.2.005	Diarrea Aguda y Crónica en el Niño	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q85, Q86	Tomo 03 · 2.2 (Pág. 22)
1.06.2.007	Hemorragia digestiva alta y baja	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q76, Q81, Q82	Tomo 03 · 5.3 (Pág. 57)

ÍNDICE CORRELATIVO OFICIAL PERFIL V3

Gastroenterología · Códigos en Orden Numérico Correlativo Estricto (Sin Bloques)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
1.01.1.001	Cirugía Pediátrica Digestiva: Urgencias y Malformaciones	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q89, Q90	Tomo 01 · 2.2 (Pág. 30)
1.06.1.001	Ascitis	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q37	Tomo 03 · C.4 (Pág. 12)
1.06.1.002	Cáncer de páncreas	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q1	Tomo 03 · C.2 (Pág. 8)
1.06.1.003	Cáncer de vesícula y vías biliares	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q55, Q56, Q57	Tomo 03 · C.3 (Pág. 10)
1.06.1.004	Cáncer gástrico	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q2, Q17, Q18	Tomo 03 · 1.5 (Pág. 13)
1.06.1.005	Daño Hepático Crónico e Hipertensión Portal	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q54	Tomo 03 · 3.3 (Pág. 39)
1.06.1.006	Colelitiasis	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q58, Q59, Q60, Q61, Q62, Q63, Q69, Q70	Tomo 03 · 4.1 (Pág. 46)
1.06.1.007	Colestasia	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q38, Q49, Q50	Tomo 03 · 3.1 (Pág. 35)
1.06.1.008	Trastornos digestivos funcionales	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	—	Q19, Q29, Q30	Tomo 03 · 2.1 (Pág. 20)
1.06.1.009	Constipación	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	—	Q73	Tomo 03 · C.8 (Pág. 20)
1.06.1.010	Diarrea asociada a antibióticos	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	—	Q64	Tomo 03 · C.9 (Pág. 22)
1.06.1.011	Diarrea crónica	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q3	Tomo 03 · C.10 (Pág. 24)
1.06.1.012	Diarrea en inmunosuprimidos	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q20	Tomo 03 · Gastroenterología (Pág. 8)
1.06.1.013	Disfagia	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q4, Q13, Q14	Tomo 03 · 1.3 (Pág. 9)
1.06.1.014	Dispepsia	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	—	Q74	Tomo 03 · Gastroenterología (Pág. 8)
1.06.1.015	Enfermedad celiaca	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	—	Q21, Q33, Q34	Tomo 03 · 2.3 (Pág. 24)
1.06.1.016	Enfermedad diverticular complicada	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q5	Tomo 03 · Gastroenterología (Pág. 8)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
1.06.1.017	Enfermedad diverticular no complicada	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	—	Q22	Tomo 03 · Gastroenterología (Pág. 8)
1.06.1.018	Enfermedad inflamatoria intestinal	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q23, Q35, Q36	Tomo 03 · 2.4 (Pág. 26)
1.06.1.019	Hepatitis aguda A no complicada	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	—	Q39, Q51, Q52, Q53	Tomo 03 · 3.2 (Pág. 37)
1.06.1.020	Hepatitis agudas B, C, por otros virus, por drogas y tóxicas	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q40	Tomo 03 · Gastroenterología (Pág. 8)
1.06.1.021	Hepatitis crónica	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q41	Tomo 03 · Gastroenterología (Pág. 8)
1.06.1.022	Insuficiencia hepática crónica	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q42	Tomo 03 · Gastroenterología (Pág. 8)
1.06.1.023	Intolerancia a la lactosa	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	—	Q24	Tomo 03 · Gastroenterología (Pág. 8)
1.06.1.024	Masa hepática	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q43	Tomo 03 · 3.4 (Pág. 41)
1.06.1.025	Pancreatitis crónica	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q65	Tomo 03 · Gastroenterología (Pág. 8)
1.06.1.026	Parasitosis intestinales	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	—	Q25	Tomo 03 · Gastroenterología (Pág. 8)
1.06.1.027	Reflujo gastroesofágico	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	—	Q6, Q9, Q10, Q87, Q88	Tomo 03 · 1.1 (Pág. 5)
1.06.1.028	Síndrome de malabsorción	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q26	Tomo 03 · Gastroenterología (Pág. 8)
1.06.1.029	Tumores de colon	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q27	Tomo 03 · 2.5 (Pág. 28)
1.06.1.030	Úlcera péptica	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	—	Q7, Q11, Q12	Tomo 03 · 1.2 (Pág. 7)
1.06.2.001	Abdomen agudo	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q75, Q77, Q78, Q79, Q80	Tomo 03 · 5.1 (Pág. 53)
1.06.2.002	Afagia aguda	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q8, Q15, Q16, Q83, Q84	Tomo 03 · 1.4 (Pág. 11)
1.06.2.003	Colangitis	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q66	Tomo 03 · Gastroenterología (Pág. 8)
1.06.2.004	Colecistitis aguda	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q67	Tomo 03 · Gastroenterología (Pág. 8)
1.06.2.005	Diarrea aguda	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	—	Q28, Q31, Q32, Q85, Q86	Tomo 03 · 2.2 (Pág. 22)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
1.06.2.006	Encefalopatía hepática	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q44	Tomo 03 · Gastroenterología (Pág. 8)
1.06.2.007	Hemorragia digestiva alta y baja	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q76, Q81, Q82	Tomo 03 · 5.3 (Pág. 57)
1.06.2.008	Hepatitis aguda A complicada	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q45	Tomo 03 · Gastroenterología (Pág. 8)
1.06.2.009	Insuficiencia hepática aguda	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q46	Tomo 03 · Gastroenterología (Pág. 8)
1.06.2.010	Pancreatitis aguda	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q68, Q71, Q72	Tomo 03 · 4.2 (Pág. 48)
1.06.2.011	Peritonitis bacteriana espontánea del cirrótico	Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar**	—	Q47	Tomo 03 · Gastroenterología (Pág. 8)
1.06.2.012	Síndrome hepatorrenal	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q48	Tomo 03 · Gastroenterología (Pág. 8)

SECCIÓN I · CUADERNILLO DE PREGUNTAS (1 A 90)

Organizado estrictamente por Bloques Cardinales · Responda sin consultar la solución

90 ÍTEMS

BLOQUE 1 ESÓFAGO Y ESTÓMAGO

PREGUNTA 1 1.06.1.002

1. Un paciente de 60 años consulta por ictericia de dos semanas de evolución, que ha ido en aumento y se ha asociado a orinas oscuras. Como antecedente, es hipertenso y fumador de 5 paquetes-año. Su examen Fsico muestra ictericia de escleras y piel, sin alteraciones en el examen abdominal. Se solicitan pruebas hepá8cas que muestran SGOT: 72 U/L, SGPT: 48 U/L, GGT: 115 U/L, fosfatasa alcalina 200: U/L y bilirrubina: 4,9 mg/dL, de predominio directo. Se realiza ecograFa abdominal que muestra vesícula biliar dilatada de 16 × 8 cm y dilatación de la vía biliar intrahepá8ca y extrahepá8ca. ¿Cuál es el diagnós8co más probable?

A) Tumor de páncreas
B) Colangiocarcinoma
C) Colangi2s esclerosante primaria
D) Diveraculo duodenal
E) Colangi2s infecciosa

PREGUNTA 2 1.06.1.004

2. Un paciente de 55 años con pirosis, que es mayor postprandial, que inició hace 2 meses y que ha aumentado en el último tiempo. Además presenta baja de peso de 4 kilogramos en dicho periodo y refiere dolor abdominal, que aumenta al palpal el epigastrio. Además en el último tiempo se han agregado vómitos postprandiales. ¿Cuál es el examen que debe solicitarse para estudiar a este paciente?

A) Endoscopía digestiva alta
B) pH-metría de 24 horas
C) TAC de abdomen
D) Ecografía abdominal
E) Marcadores tumorales

PREGUNTA 3 1.06.1.011

3. Una paciente de 53 años presenta cambio del hábito intestinal, caracterizado por diarrea acuosa, de 3 meses de evolución, asociada a dolor abdominal ocasional. Además, ha bajado 4 kilogramos de peso, desde el inicio de los síntomas. Se realizan exámenes de sangre, entre los que destacan hematocrito: 30%, Hemoglobina: 9,7 g/dl y VCM: 69 fl, albúmina: 2,8 g/dl y GOT: 40 UI/L. Tiene antecedente de un hijo con enfermedad celíaca. ¿Cuál es el examen de elección para proseguir el estudio en esta paciente?

A) Endoscopía digestiva alta, con biopsia de duodeno
B) Ecografía abdominal
C) Colonoscopía
D) Detección de anticuerpos antitransglutaminasa en sangre
E) Test de sangre oculta en deposiciones

PREGUNTA 4 1.06.1.013

4. Paciente de 80 años, con antecedente de hipertensión, diabetes insulinodependiente con mal control metabólico y epigastralgia en tratamiento crónico con omeprazol, consulta por cuadro de disfagia lógica asociado a odinofagia de un mes de evolución. Al examen físico no se encuentran alteraciones. El diagnóstico más probable es:

A) Cáncer esofágico
B) Reflujo gastroesofágico
C) Acalasia
D) Candidiasis esofágica
E) Divertículo esofágico

PREGUNTA 5 1.06.1.016

5. Un paciente se realiza una colonoscopía, para la resección de unos pólipos intestinales. Algunas horas después presenta dolor abdominal bajo, asociado a hematoquezia escasa y malestar general. Al examen físico presenta dolor a la palpación de la fosa iliaca izquierda. ¿Qué examen es el más adecuado para proseguir con el estudio en este paciente?

A) Resonancia magnética nuclear de abdomen y pelvis
B) Ecografía abdominal y pélvica
C) Colonoscopía
D) Radiografía de abdomen y pelvis
E) TAC de abdomen y pelvis

PREGUNTA 6 1.06.1.027

6. Un hombre de 30 años presenta pirosis frecuente, por lo que se solicita una endoscopía digestiva alta, que muestra una esofagitis por reflujo, grado A. Se inician inhibidores de la bomba de protones por 6 meses. Al control refiere buena respuesta, sin embargo, los síntomas recurren al suspender el tratamiento. La conducta más adecuada es:

A) Repetir la endoscopía digestiva alta
B) Solicitar pH-metría esofágica
C) Indicar inhibidores de la bomba de protones
D) Solicitar manometría esofágica
E) Cambiar a antihistamínicos H2

PREGUNTA 7 1.06.1.030

7. **Paciente de 27 años, sin antecedentes mórbidos, consulta por cuadro de 3 meses de dolor epigástrico tipo urente que aumenta durante los periodos de ayuno y estrés, asociado ocasionalmente a pirosis. Se realiza endoscopía digestiva alta que objetiva úlcera duodenal activa y se realiza test de ureasa que resulta (-). La conducta más adecuada en este caso es:**

A) Iniciar omeprazol, amoxicilina y claritromicina
B) Indicar omeprazol y controlar con nueva endoscopía en 6 semanas
C) Solicitar nueva endoscopía digestiva alta con test de ureasa
D) Iniciar omeprazol, bismuto y metronidazol
E) Iniciar medidas anti reflujo y omeprazol a permanencia.

PREGUNTA 8 1.06.2.002

8. **Disfagia a nivel de xifoides luego de comer pollo, que no permitía el paso de agua. Conducta:**

A) EDA
B) Radiografía
C) Nasolaringoscopia
D) Manometría esofágica
E) Derrame pleural

PREGUNTA 9 1.06.1.027

9. **Hombre de 27 años, sin antecedentes, consulta por 3 meses de dolor epigástrico urente que aumenta con el ayuno y el estrés, con pirosis ocasional. La endoscopía digestiva alta muestra una úlcera duodenal activa y el test de ureasa resulta negativo. No usa AINE. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Iniciar omeprazol, amoxicilina y claritromicina por 14 días
B) Indicar omeprazol y repetir la endoscopía en 6 semanas
C) Solicitar una nueva endoscopía con test de ureasa
D) Iniciar medidas antirreflujo y omeprazol a permanencia
E) Indicar solo omeprazol por 8 semanas y control clínico

PREGUNTA 10 1.06.1.027

10. **Paciente con úlcera gástrica y test de ureasa positivo recibe amoxicilina, claritromicina y omeprazol por 10 días, seguido de omeprazol por 4 semanas. El control con test de ureasa a las 6 semanas post-tratamiento sigue positivo. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Repetir el mismo esquema por 14 días
B) Realizar endoscopía digestiva alta con biopsias
C) Indicar terapia erradicadora de segunda línea
D) Repetir el test de ureasa en 3 meses
E) Observar la evolución clínica

PREGUNTA 11 1.06.1.030

11. **Hombre de 40 años con úlcera duodenal en la endoscopía. El test de ureasa para H. pylori resulta negativo. No usa AINE. ¿Cuál es la conducta respecto de la erradicación?**

A) No erradicar, porque el test de H. pylori es negativo
B) Erradicar igualmente con esquema de primera línea
C) Indicar solo omeprazol por 6 semanas
D) Repetir la endoscopía en 4 semanas antes de decidir
E) Solicitar antígeno fecal y erradicar solo si es positivo

PREGUNTA 12 1.06.1.030

12. **Mujer de 35 años con epigastralgia urente de 2 meses, sin baja de peso, anemia ni disfagia. La endoscopía digestiva alta es completamente normal y el test de H. pylori es negativo. ¿Cuál es el diagnóstico y la conducta inicial?**

A) Úlcera péptica; iniciar terapia de erradicación
B) Cáncer gástrico incipiente; repetir endoscopía con cromoendoscopia
C) Dispepsia funcional; educación, manejo del estrés y prueba con IBP
D) Gastroparesia; solicitar cintigrafía de vaciamiento gástrico
E) ERGE; iniciar IBP a permanencia y cirugía antirreflujo

PREGUNTA 13 1.06.1.013

13. **Hombre de 62 años, fumador de 40 paquetes-año, consulta por 3 meses de disfagia que comenzó con la carne y el pan y ahora también le cuesta tragar líquidos, con baja de 7 kg de peso. ¿Cuál es la conducta inicial?**

A) Manometría esofágica
B) Esofagograma con bario
C) Endoscopía digestiva alta con biopsia
D) TAC de tórax con contraste
E) Prueba terapéutica con inhibidor de la bomba de protones

PREGUNTA 14 1.06.1.013

14. **Mujer de 71 años consulta por sensación de que la comida "se le queda en la garganta" desde hace un año, regurgitación de alimentos no digeridos y halitosis intensa que le notan sus familiares. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Cáncer de esófago
B) Acalasia
C) Divertículo de Zenker
D) Esclerodermia esofágica
E) Estenosis péptica por reflujo

PREGUNTA 15 1.06.2.002

15. **Niño de 3 años que hace 2 horas bebió un sorbo de soda cáustica del envase mal rotulado. Presenta sialorrea y llanto al tragar, sin dificultad respiratoria. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?**

A) Lavado gástrico con sonda nasogástrica
B) Carbón activado por vía oral
C) Endoscopía digestiva alta en las primeras horas
D) Administrar leche o vinagre diluido para neutralizar
E) Provocar el vómito y observar

PREGUNTA 16 1.06.2.002

16. **Hombre de 45 años, tras una cena copiosa con alcohol y varios episodios de vómitos, presenta dolor torácico intenso y, al examen, crepitación a la palpación del cuello. Está febril y taquicárdico. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Síndrome de Mallory-Weiss
B) Perforación esofágica (síndrome de Boerhaave)
C) Infarto agudo de miocardio
D) Neumotórax espontáneo
E) Disección aórtica

PREGUNTA 17 1.06.1.004

17. Hombre de 60 años consulta por baja de 8 kg de peso en 3 meses, epigastralgia sorda e hiporexia. No tiene ictericia. ¿Cuál es el examen inicial más adecuado?

A) TAC de abdomen y pelvis con contraste
B) Endoscopía digestiva alta con biopsias
C) Ecografía abdominal
D) Marcadores tumorales (CEA, CA 19-9)
E) Tránsito esofagogastroduodenal con bario

PREGUNTA 18 1.06.1.004

18. Mujer de 55 años con endoscopía por dispepsia que informa un adenocarcinoma gástrico limitado a la mucosa, sin invasión de la submucosa, en una lesión de 15 mm bien diferenciada y sin úlcera. El TAC no muestra adenopatías ni metástasis. ¿Qué define el pronóstico y cuál es la conducta?

A) El tamaño de la lesión; observación con endoscopías seriadas
B) La profundidad de invasión de la pared; resección (endoscópica o quirúrgica) con intención curativa
C) La presencia de H. pylori; solo terapia de erradicación
D) El grado de diferenciación; quimioterapia paliativa
E) El nivel de CEA; radioterapia externa

BLOQUE 2 INTESTINO Y COLON

PREGUNTA 19 1.06.1.008

19. Una paciente de 45 años consulta por dolor abdominal de 4 meses de evolución, caracterizado por malestar abdominal difuso con exacerbaciones cólicas, que ha tenido una intensidad variable y que se asocia a deposiciones de consistencia dura, 8po Bristol 2, que se presentan cada 4 a 5 días, tras las cuales el dolor disminuye considerablemente. Sin embargo, también ha presentado episodios de diarrea de manera esporádica. Su examen Fsico muestra abdomen blando, sensible, sin masas, visceromegalia ni signos peritoneales. ¿Cuál es el diagnós8co más probable?

A) Síndrome de intes2no irritable con predominio de cons2pación
B) Enfermedad celíaca
C) Coli2s ulcerosa
D) Cáncer de colon
E) Cons2pación funcional

PREGUNTA 20 1.06.1.012

20. [ATENCIÓN PRIMARIA: Diarrea en inmunosuprimidos · 1.06.1.012] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Diarrea en inmunosuprimidos. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 21 1.06.1.015

21. Una paciente de 23 años, vegetariana estricta, consulta por diarrea de algunos meses de evolución, asociada a baja de peso. Se solicitan exámenes, entre los que destaca anemia ferropénica. Su examen físico no aporta mayor información. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Parasitosis intestinal
B) Enfermedad celíaca
C) Colitis ulcerosa
D) Enfermedad de Cröhn
E) Enteropatía perdedora de proteínas

PREGUNTA 22 1.06.1.017

22. [ATENCIÓN PRIMARIA: Enfermedad diverticular no complicada · 1.06.1.017] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Enfermedad diverticular no complicada. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 23 1.06.1.018

23. Joven de 25 años con diarrea crónica de 8 meses, 5-6 deposiciones al día sin sangre, pérdida de peso de 7 kg, úlceras orales recurrentes, dolor abdominal periumbilical y fístula perianal. Colonoscopía: úlceras aftosas con mucosa normal entre ellas (patrón en empedrado). ¿Cuál es el diagnóstico?

A) Síndrome de intestino irritable
B) Colitis ulcerosa
C) Enfermedad de Crohn
D) Tuberculosis intestinal
E) Linfoma intestinal

PREGUNTA 24 1.06.1.023

24. [ATENCIÓN PRIMARIA: Intolerancia a la lactosa · 1.06.1.023] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Intolerancia a la lactosa. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 25 1.06.1.026

25. [ATENCIÓN PRIMARIA: Parasitosis intestinales · 1.06.1.026] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Parasitosis intestinales. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 26 1.06.1.028

26. Una paciente de 40 años consulta por deposiciones frecuentes y diarrea de 3 meses de evolución. Presenta urgencia defecatoria, especialmente tras ingerir alimentos ricos en grasa, y nota gotas de grasa flotando en el inodoro, luego de defecar. Adicionalmente, refiere baja de peso no cuan8ficada. Su examen Fsico muestra signos vitales normales y su examen abdominal muestra abdomen blando, depresible, sin signos peritoneales ni masas. ¿Cuál es el diagnós8co más probable?

A) Enfermedad celíaca
B) Insuficiencia pancreá2ca exocrina
C) Sobrecrecimiento bacteriano
D) Coli2s ulcerosa
E) Giardiasis

PREGUNTA 27 1.06.1.029

27. Un paciente de 70 años, consulta por un cuadro de varios meses de evolución de constipación, alternado con diarrea. Su examen físico no aporta mayor información. En sus exámenes destaca hematocrito: 36% y hemoglobina de 12 g/dl. ¿Qué examen debe solicitarse a continuación?

A) Test de sangre oculta en deposiciones
B) Ecografía abdominal
C) TAC de abdomen y pelvis
D) Colonoscopía
E) Rectosigmoidoscopía

PREGUNTA 28 1.06.2.005

28. Un paciente de 34 años lleva 48 horas con dolor abdominal tipo cólico, que ha ido en aumento, asociado a deposiciones líquidas abundantes y sensación febril. Al examen físico tiene temperatura axilar: 37,1 grados Celsius, FC: 80x', PA: 120/80 mmHg, presenta dolor a la palpación del abdomen, mayor en la fosa iliaca derecha. No tiene signo de Blumberg. Se solicita una ecografía abdominal que muestra inflamación del íleon distal y del colon derecho y se ve el apéndice con leve edema de la pared y un coprolito en su base. ¿Cuál es el

A) Apendicitis aguda
B) Enteritis infecciosa
C) Diverticulitis aguda
D) Enfermedad de Cröhn
E) Colitis isquémica

PREGUNTA 29 1.06.1.008

29. Mujer de 48 años consulta por distensión y dolor abdominal de 1 año, alternando diarrea y constipación. En los últimos 2 meses refiere deposiciones más frecuentes, baja de 4 kg de peso no buscada y un episodio de rectorragia. Su madre tuvo cáncer de colon a los 55 años. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Diagnosticar síndrome de intestino irritable e iniciar dieta baja en FODMAP
B) Solicitar colonoscopía
C) Indicar antiespasmódicos y control en 3 meses
D) Solicitar test de sangre oculta en deposiciones y repetir en 1 año
E) Iniciar amitriptilina en dosis baja

PREGUNTA 30 1.06.1.008

30. **Hombre de 29 años consulta por dolor abdominal recurrente de 6 meses que alivia al defecar, asociado a deposiciones más blandas cuando aparece el dolor. Sin baja de peso, anemia ni antecedentes familiares. Hemograma, PCR y anticuerpos anti-transglutaminasa normales. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Colonoscopía para descartar enfermedad inflamatoria intestinal
B) Diagnóstico de síndrome de intestino irritable e iniciar manejo
C) Endoscopía digestiva alta con biopsias duodenales
D) TAC de abdomen y pelvis con contraste
E) Prueba terapéutica con inhibidor de la bomba de protones

PREGUNTA 31 1.06.2.005

31. **Hombre de 46 años presenta diarrea líquida de 3 semanas que comenzó 10 días después de terminar un tratamiento con amoxicilina-clavulánico por una neumonía. Sin sangre en las deposiciones. ¿Cuál es el examen más adecuado para confirmar la etiología?**

A) Coprocultivo corriente
B) PCR de toxina para Clostridioides difficile en deposiciones
C) Parasitológico seriado de deposiciones
D) Colonoscopía con biopsias
E) Calprotectina fecal

PREGUNTA 32 1.06.2.005

32. **Niño de 2 años con diarrea acuosa de 2 días y fiebre de 38,5 °C, sin sangre en las deposiciones, con buen estado general y sin signos de deshidratación. ¿Cuál es la conducta respecto de los antibióticos?**

A) Ciprofloxacino oral
B) Ceftriaxona endovenosa
C) Azitromicina oral
D) No indicar antibióticos
E) Metronidazol oral

PREGUNTA 33 1.06.1.015

33. **Paciente con enfermedad celíaca que lleva 1 año con dieta sin gluten. Refiere seguirla de forma estricta, pero persiste con diarrea y baja de peso. Los anticuerpos anti-transglutaminasa están negativos. ¿Cuál es la sospecha diagnóstica?**

A) Transgresión oculta de la dieta
B) Linfoma T asociado a enteropatía (linfoma MALT)
C) Intolerancia a la lactosa secundaria
D) Síndrome de intestino irritable sobreagregado
E) Giardiasis crónica

PREGUNTA 34 1.06.1.015

34. **Recién nacido de 12 días con ictericia prolongada, hepatomegalia, mal incremento ponderal y cataratas bilaterales detectadas en el examen ocular. ¿Cuál es el tratamiento nutricional indicado?**

A) Mantener lactancia materna exclusiva
B) Fórmula sin lactosa
C) Fórmula de soya (sin galactosa)
D) Fórmula extensamente hidrolizada
E) Suplemento oral de lactasa con leche materna

PREGUNTA 35 1.06.1.018

35. **Hombre de 25 años con 1 mes de diarrea, dolor abdominal y malestar general; ha tenido disentería en algunas ocasiones y bajó 4 kg. La colonoscopía muestra signos de inflamación en el colon, con zonas de mucosa indemne y sin afectación del recto. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Colitis ulcerosa
B) Enfermedad de Crohn
C) Colitis isquémica
D) Parasitosis intestinal
E) Colitis por Clostridioides difficile

PREGUNTA 36 1.06.1.018

36. **Paciente de 45 años con antecedente de colitis ulcerosa diagnosticada a los 20 años, inactiva hace 10 años. Desde hace una semana presenta deposiciones blandas con escasa sangre. El examen físico no aporta información. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Solicitar rectosigmoidoscopía
B) Solicitar TAC de abdomen y pelvis
C) Solicitar parasitológico de deposiciones
D) Solicitar colonoscopía
E) Iniciar corticoides orales

BLOQUE 3 HÍGADO

PREGUNTA 37 1.06.1.001

37. **Un paciente fumador de 20 paquetes-año, que consume cerca de 5 g de alcohol al día los fines de semana, presenta moles8as abdominales inespecíficas y distensión abdominal progresiva desde hace 3 meses, a lo que en el úl8mo 8empo se agregó dolor abdominal. Se observa el paciente enflaquecido, con FC: 70x', PA: 130/80 mmHg y, en el examen abdominal, se constata asci8s a tensión, sin circulación colateral. Se solicitan exámenes de laboratorio que muestran GOT: 48 U/L, GPT: 37 U/L, GGT: 59 U/L, bilirrubina total: 1,3 mg/dL, bilirrubina directa: 0,3 mg/dL, protrombinemia: 80% y albuminemia: 2,9 g/dL. Además, se realiza paracentesis diagnós8ca que muestra líquido ascí8co con 680 células/mm³, 80% mononucleares y 20% polimorfonucleares, glucosa: 116 mg/dL, proteínas: 1,36 g/dL y ADA: 3,4 U/L. ¿Cuál es el diagnós8co más probable?**

A) Peritoni2s bacteriana espontánea
B) Asci2s por hipertensión portal
C) Síndrome nefró2co
D) Tuberculosis peritoneal
E) Carcinomatosis peritoneal

PREGUNTA 38 1.06.1.007

38. **Una paciente de 54 años, se realiza exámenes como parte de chequeo médico, que muestran SGOT: 43 UI/L, SGPT: 70 UI/L, GGT: 433 UI/L, FA: 531 UI/L, bilirrubina total: 3,0 mg/dl, albúmina: 3,7 g/dl y protrombinemia: 88%. ¿Cuál es el diagnóstico de sospecha?**

A) Colestasia por esteatosis hepática
B) Cirrosis biliar primaria
C) Colestasia por compresión externa
D) Colangitis esclerosante primaria
E) Colangitis esclerosante secundaria

PREGUNTA 39 1.06.1.019

39. **Un paciente de 32 años regresa de un viaje a un país vecino. A los pocos días presenta un cuadro de 5 días de fiebre, asociado a malestar general, que es seguido luego de dolor abdominal, ictericia y orinas oscuras. Al examen físico está ictérico, con dolor a la palpación del hipocondrio derecho. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Hepatitis A
B) Hepatitis B
C) Hepatitis alcohólica
D) Colédocolitiasis
E) Fiebre tifoidea

PREGUNTA 40 1.06.1.020

40. **Una paciente de 20 años, en tratamiento con isotretinoína, desde hace 10 días, por acné, consulta por dolor abdominal, asociada a malestar general y astenia, a lo que se ha agregado ictericia y orinas oscuras. En su examen físico se aprecia ictericia de piel y mucosas y su abdomen se palpa bando, doloroso en epigastrio e hipocondrio, con hígado palpable 3 cm por debajo del reborde costal. Sus pruebas hepáticas resultan GOT: 328 UI/L, GPT: 459 UI/L, bilirrubina: 1,8 mg/dl, FA: 80 UI/L, GGT: 92 UI/L, protrombinemia: 80%. Además, se solicita serología que muestra IgG(+)VHA, IgM(-)VHA, Antígeno VHBs(-), Anticuerpos totales antiHBVc(+). Anticuerpos anti-VHC y marcadores de autoinmunidad pendientes. El diagnóstico más probable es:**

A) Hepatitis A
B) Hepatitis B
C) Hepatitis C
D) Hepatitis por drogas
E) Hepatitis autoinmune

PREGUNTA 41 1.06.1.021

41. **Un paciente asintomático se realiza pruebas hepáticas como parte de un chequeo médico, que muestran una SGOT: 432 UI/L y SGPT: 310 UI/L. No refiere hábitos tóxicos. Como antecedente, tuvo un hemoperitoneo el año 1992, que requirió de transfusiones. ¿Qué examen se debe solicitar ante la sospecha diagnóstica?**

A) Antígeno de superficie de VHB
B) IgM para VHA
C) Test de HOMA
D) Anticuerpos antinucleares y anticitoplasma de neutrófilo
E) Anticuerpos totales contra VHC

PREGUNTA 42 1.06.1.022

42. **[ATENCIÓN PRIMARIA: Insuficiencia hepática crónica · 1.06.1.022] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Insuficiencia hepática crónica. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 43 1.06.1.024

43. **Una paciente de 70 años de edad, con antecedente de cirrosis hepática, sin hábito alcohólico actual, VHBsAg (-) y Anticuerpos anti-VHC (-), Child Pugh clase A, MELDS: 8 puntos, se realiza una ecografía abdominal, que muestra una lesión sólida, en el lóbulo hepático derecho, de 3,5 cm y aspecto hipoecogénico. En su laboratorio destaca alfafetoproteína de 5,3 ng/ml (VN: 0-7 ng/ml) El diagnóstico más probable es:**

A) Metastásis hepática
B) Adenoma hepático
C) Carcinoma hepatocelular
D) Quiste hepático
E) Hemangioma hepático

PREGUNTA 44 1.06.2.006

44. **Un paciente con antecedente de daño hepático crónico por alcohol, presenta desorientación, lenguaje incoherente y tendencia a la somnolencia. Al examen físico presenta ictericia, arañas vasculares en la cara y el pecho, asterixis y compromiso cualitativo de conciencia. ¿Qué fármaco es el más adecuado para su tratamiento?**

A) Amonio
B) N-acetil-cisteína
C) Risperidona
D) Donepezilo
E) Lactulosa

PREGUNTA 45 1.06.2.008

45. **Una paciente de 30 años consulta por un cuadro de 10 días de evolución caracterizado por astenia, fiebre, malestar general y dolor epigástrico. Hace dos días se agregó ictericia de piel y escleras el día de hoy presentó orinas oscuras. Al examen físico tiene FC: 96x', PA: 100/60 mmHg, con ictericia franca en escleras y piel, sin alteraciones en el nivel de conciencia. En el examen abdominal se observa dolor a la palpación epigástrica y del hipocondrio derecho, sin signos peritoneales ni visceromegalia; los ruidos hidroaéreos están conservados. Se solicitan exámenes, que muestran GOT: 2.640 UI/L, GPT: 2.860 UI/L, GGT: 180 UI/L, FA: 412 UI/L, protrombinemia: 52%, bilirrubina total: 9,2 mg/dl, fracción directa: 6,6 mg/dl, albúmina plasmática: 3,4 g/dl. Se solicita IgM para virus hepatitis A, que resulta 5,5 UI (VN: menor a 0,2). ¿Cuál es la conducta más adecuada con esta paciente?**

A) Dieta blanda y reposo en domicilio
B) Hospitalizar
C) Solicitar ecografía abdominal y controlar ambulatoriamente
D) Solicitar una colangiopancreatografía por resonancia magnética nuclear
E) Indicar N-acetil-cisteína oral

PREGUNTA 46 1.06.2.009

46. **[URGENCIA: Insuficiencia hepática aguda · 1.06.2.009] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Insuficiencia hepática aguda. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 47 1.06.2.011

47. **Una paciente de 55 años, con antecedente de daño hepático crónico por virus hepatitis C, consulta por cuadro de malestar general, asociado a febrículas, confusión y aumento de perímetro abdominal. Al examen abdominal destaca matidez desplazable. Se realiza paracentesis diagnóstica que muestra transudado y presencia de 300 leucocitos (100% polimorfonucleares). La conducta más adecuada en este caso es:**

A) Administrar albúmina endovenosa
B) Realizar paracentesis evacuadora
C) Observar
D) Administrar antibióticos de forma empírica
E) Iniciar terapia con furosemida y espironolactona

PREGUNTA 48 1.06.2.012

48. **[URGENCIA: Síndrome hepatorrenal · 1.06.2.012] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Síndrome hepatorrenal. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 49 1.06.1.007

49. **Estudiante de 22 años, asintomático, consulta porque en un examen preventivo le encontraron una bilirrubina total de 2,6 mg/dL, a expensas de la indirecta. Las transaminasas, fosfatasas alcalinas, GGT, hemograma y LDH son normales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y la conducta?**

A) Hepatitis viral aguda; solicitar serología viral y control seriado
B) Anemia hemolítica; frotis y test de Coombs
C) Síndrome de Gilbert; tranquilizar y no requiere tratamiento
D) Coledocolitiasis; ecografía abdominal urgente
E) Cirrosis biliar primaria; anticuerpos antimitocondriales

PREGUNTA 50 1.06.1.007

50. **Mujer de 55 años con dolor cólico en el hipocondrio derecho e ictericia de 2 días, sin fiebre. Laboratorio: bilirrubina 4 mg/dL de predominio directo, fosfatasas alcalinas y GGT elevadas, transaminasas levemente altas. La ecografía muestra colelitiasis y una vía biliar de 9 mm, sin visualizar cálculos en el colédoco. ¿Cuál es el siguiente examen?**

A) CPRE directa
B) Colangiorresonancia
C) TAC de abdomen con contraste
D) Biopsia hepática percutánea
E) Repetir la ecografía en 48 horas

PREGUNTA 51 1.06.1.019

51. **Una paciente se realiza exámenes porque su pareja fue diagnosticada de hepatitis B. Tiene antígeno de superficie para VHB (AgHBs) negativo y anticuerpos anti-HBs (antisuperficie) positivos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Vacunada contra la hepatitis B
B) Hepatitis B aguda
C) Hepatitis B crónica
D) Hepatitis B en período de ventana
E) Infección asintomática por virus hepatitis B

PREGUNTA 52 1.06.1.019

52. **Mujer de 30 años con 10 días de astenia, fiebre, malestar y dolor epigástrico; hace 2 días se agregó ictericia y hoy orinas oscuras. Al examen: FC 96/min, PA 100/60, ictericia franca, sin compromiso de conciencia, dolor en epigastrio e hipocondrio derecho sin signos peritoneales. Laboratorio: GOT 2.640 U/L, GPT 2.860 U/L, GGT 180, FA 412, protrombinemia 52 %, bilirrubina total 9,2 mg/dL (directa 6,6), albúmina 3,4 g/dL. IgM anti-VHA 5,5 U (VN < 0,2). ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Dieta blanda y reposo en domicilio
B) Hospitalizar
C) Solicitar ecografía abdominal y controlar de forma ambulatoria
D) Solicitar colangiopancreatografía por resonancia magnética
E) Indicar N-acetilcisteína oral

PREGUNTA 53 1.06.1.019

53. **Mujer de 20 años en tratamiento con isotretinoína hace 10 días por acné consulta por dolor abdominal, malestar y astenia, con ictericia y orinas oscuras. Examen: ictericia, dolor en epigastrio e hipocondrio, hígado palpable 3 cm bajo el reborde costal. Laboratorio: GOT 328 U/L, GPT 459 U/L, bilirrubina 1,8 mg/dL, FA 80, GGT 92, protrombinemia 80 %. Serología: IgG anti-VHA (+), IgM anti-VHA (−), AgHBs (−), anti-HBc totales (+); anti-VHC y autoinmunidad pendientes. El diagnóstico más probable es:**

A) Hepatitis A
B) Hepatitis B
C) Hepatitis C
D) Hepatitis por fármacos
E) Hepatitis autoinmune

PREGUNTA 54 1.06.1.005

54. **Paciente con cirrosis y várices esofágicas medianas encontradas en una endoscopía de tamizaje. Nunca ha presentado hemorragia digestiva. ¿Cuál es la profilaxis indicada?**

A) Ligadura endoscópica de várices + propranolol
B) Propranolol (o carvedilol) por vía oral, titulado por frecuencia cardíaca
C) Instalación electiva de TIPS
D) Terlipresina endovenosa mensual
E) Ácido tranexámico oral permanente

BLOQUE 4 VÍA BILIAR Y PÁNCREAS

PREGUNTA 55 1.06.1.003

55. **Una paciente de 91 años, diabética, con antecedente de cólicos biliares a repetición, consulta por astenia, decaimiento, ictericia marcada y orinas oscuras, de 3 semanas de evolución, asociadas a dolor epigástrico moderado. Al examen físico, se aprecia ictericia de piel y mucosas y se palpa una masa en el hipocondrio derecho. Se solicitan pruebas hepáticas, que muestran SGOT: 60 UI/L, SGPT: 56 UI/L, GGT: 570 UI/L, FA: 755 UI/L, bilirrubina total: 21 mg/dl, bilirrubina directa: 19 UI/L. El diagnóstico más probable es:**

A) Cáncer de la cabeza de páncreas
B) Cáncer de vesícula
C) Colangiocarcinoma
D) Hepatocarcinoma
E) Cáncer de la ampolla de Vater

PREGUNTA 56 1.06.1.003

56. **Una paciente de 82 años con antecedente de colecistectomía hace 5 años, consulta por un cuadro de 2 semanas de evolución caracterizado por ictericia y coluria, asociado a decaimiento. Niega dolor, pero refiere que ha bajado de peso en los últimos meses. Sus signos vitales son normales y se observa en buen estado general, orientada e hidratada, con ictericia de piel y escleras. Al examen abdominal no se palpan masas ni signos peritoneales. Los exámenes de laboratorio revelan fosfatasas alcalinas: 422 UI/L, GGT: 322 UI/L, GOT: 110 UI/L, GPT: 75 UI/L, protrombinemia: 90% y albúmina sérica: 3,1 g/dl. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Cáncer de páncreas
B) Coledocolitiasis residual
C) Cáncer de duodeno
D) Cáncer de la vía biliar
E) Colangitis esclerosante primaria

PREGUNTA 57 1.06.1.003

57. **Una paciente de 35 años, presenta dolor en el hipocondrio izquierdo, asociado a meteorismo, por lo que se realiza una ecografía abdominal, que visualiza un pólipo en el fondo vesicular, de 4 mm de diámetro, homogéneo y se observa la vía biliar de 5 mm de diámetro. La conducta más adecuada es:**

A) Control ecográfico en 6 meses
B) Solicitar una TAC de abdomen y pelvis
C) Solicitar una resonancia magnética nuclear abdominal
D) Realizar biopsia del pólipo
E) Realizar colecistectomía laparoscópica

PREGUNTA 58 1.06.1.006

58. **Una paciente de 40 años, IMC: 30, presenta dolor intermitente en el hipocondrio derecho, desde hace 3 meses, que cede espontáneamente. Se realiza una ecografía, que se muestra a continuación: Fuente: www.radiopaedia.org El diagnóstico más probable es:**

A) Colelitiasis
B) Coledocolitiasis
C) Colangiocarcinoma
D) Cáncer de vesícula
E) Colecistitis

PREGUNTA 59 1.06.1.006

59. **Un paciente presenta hace una semana dolor en el hipocondrio derecho, intenso, asociado a vómitos, que cede espontáneamente. Actualmente está en buenas condiciones, asintomático, sin alteraciones en el examen físico. ¿Qué examen es el más adecuado para estudiar a este paciente?**

A) Ecografía abdominal
B) Radiografía de abdomen
C) Amilasa / Lipasa
D) Colangioresonancia
E) TAC de abdomen

PREGUNTA 60 1.06.1.006

60. **Embarazada de 32 semanas con sx de cole. Eco pared engrosada con calculos y VB 9 o 10 cm. Conducta:**

A) Analgesia hasta fin del embarazo
B) CPRE (PORQ ESTA NO PODRIA SER???)- SGY Porque no tenía clínica de colangitis, que sería la indicación de drenaje inmediato. Sino sólo sospecha de coledocolitiasis.
C) colecistectomía+CIO
D) colecistostomía
E) Colangioresonancia

PREGUNTA 61 1.06.1.006

61. **Mujer de 45 años operada de colecistectomía hace 6 meses. Ahora con dolor cólico en hipocondrio derecho, ictericia leve y coledocolitiasis residual confirmada por ecografía. ¿Cuál es el manejo?**

A) CPRE con esfinterotomía y extracción del cálculo
B) Reoperación para exploración de vía biliar
C) Tratamiento médico con ácido ursodesoxicólico
D) Observar y controlar en 3 meses
E) Litotricia extracorpórea

PREGUNTA 62 1.06.1.006

62. **Un paciente de 55 años consulta por dolor abdominal, de 3 días de evolución, mayor en el epigastrio, asociado a vómitos alimentarios. Su examen abdominal muestra dolor a la palpación del epigastrio e hipocondrio derecho. Se realiza una ecografía abdominal, que muestra vía biliar de 8 mm, con múltiples cálculos en la vesícula, de pequeño tamaño. Se solicitan pruebas hepáticas con fosfatasas alcalinas: 520 UI/L, GGT: 612 UI/L, GOT: 102 UI/L y GPT: 87 UI/L, bilirrubinemia: 6,0 mg/dl, con fracción directa de 4,6 mg/dl. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?**

A) Realizar colangiopancreatografía endoscópica retrógrada
B) Indicar colangioresonancia
C) Solicitar TAC de abdomen y pelvis
D) Resolver quirúrgicamente
E) Indicar tratamiento analgésico y antibiótico endovenoso

PREGUNTA 63 1.06.1.006

63. **Un paciente de 50 años, en tratamiento con antimicóticos orales desde hace 3 se- manas, consulta por un cuadro de 2 días de evolución de prurito, ictericia y acolia, sin dolor. En su examen físico se aprecia ictérico, afebril, con FC: 70x', PA: 110/70 mmHg, con abdomen blando, depresible. Se solicitan pruebas hepáticas, que muestran un pa- trón colestásico y la ecografía abdominal demuestra vesícula biliar con barro biliar y colédoco de 10 mm diámetro. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Coledocolitiasis
B) Colestasia farmacológica
C) Síndrome de Mirizzi
D) Esteatosis hepática
E) Colelitiasis

PREGUNTA 64 1.06.1.010

64. **Puérpera de 5 días con deposiciones líquidas múltiples con moco y sangre, calambres abdominales y fiebre 38.5°C. Hospitalizada durante el parto. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Infección por Clostridioides difficile
B) Gastroenteritis viral
C) Colitis ulcerosa de novo
D) Salmonelosis
E) Síndrome de intestino irritable postinfeccioso

PREGUNTA 65 1.06.1.025

65. **Hombre de 55 años, alcohólico crónico y fumador, con dolor epigástrico que se irradia a la espalda, aparece con la ingesta de alimentos y se calma al inclinarse hacia adelante. Presenta baja de peso de 8 kg. Transaminasas y amilasa levemente elevadas. Radiografía: calcificaciones en epigastrio. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Úlcera gástrica perforada
B) Obstrucción intestinal
C) Pancreatitis crónica
D) Colecistitis aguda
E) Hepatitis alcohólica

PREGUNTA 66 1.06.2.003

66. **Una paciente de 52 años consulta por dolor abdominal de 12 horas de evolución, intenso, de localización epigástrica e irradiado a los flancos, que se asocia a vómitos y orinas oscuras. Además, ha presentado fiebre hasta 39°C y aumento del dolor abdominal, en especial en el hemiabdomen superior. Al examen físico tiene ictericia de escleras, piel y mucosas, PA: 90/60 mmHg y FC: 110x'. Se realiza una ecografía abdominal que muestra colédoco de 11 mm de dilatación y litiasis múltiple en la vesícula biliar. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Realizar colecistectomía laparoscópica
B) Realizar colecistectomía abierta más coledocostomía
C) Solicitar colangioresonancia magnética nuclear
D) Solicitar TAC de abdomen y pelvis
E) Realizar drenaje endoscópico de la vía biliar

PREGUNTA 67 1.06.2.004

67. **[URGENCIA: Colecistitis aguda · 1.06.2.004] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Colecistitis aguda. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 68 1.06.2.010

68. **Un paciente obeso, con antecedente de hígado graso. Luego de una trasgresión ali- mentaria con abundante consumo de alcohol, presenta cuadro de dolor epigástrico irradiado a ambos costados, asociado a vómitos alimentarios, sensación febril e icteri- cia. Al examen físico, su presión arterial es de 110/70mmHg, con frecuencia cardiaca 100 por minuto, y al examen abdominal presenta dolor a la palpación de forma difusa, con abolición de ruidos hidroaéreos. El diagnóstico más probable es:**

A) Isquemia mesentérica
B) Colangitis
C) Pancreatitis
D) Colecistitis
E) Coledcolitiasis

PREGUNTA 69 1.06.1.006

69. **Hombre de 62 años consulta por dolor en el hipocondrio derecho, ictericia progresiva, fiebre de 39 °C con calofríos y, en las últimas horas, tendencia a la somnolencia y presión arterial de 90/50 mmHg. ¿Cuál es el diagnóstico y la conducta prioritaria?**

A) Colecistitis aguda; colecistectomía laparoscópica de urgencia
B) Colangitis aguda grave; reposición de volumen, antibióticos y CPRE urgente para drenaje
C) Coledocolitiasis; colangiorresonancia y luego CPRE electiva
D) Hepatitis aguda; manejo de soporte
E) Absceso hepático; antibióticos y drenaje percutáneo

PREGUNTA 70 1.06.1.006

70. **Mujer de 40 años, sin síntomas, a quien en una ecografía de rutina se le detecta una colelitiasis (múltiples cálculos, vesícula de pared normal). ¿Cuál es la conducta?**

A) Observación; operar solo si aparecen síntomas
B) Ácido ursodesoxicólico para disolver los cálculos
C) Colecistectomía laparoscópica electiva
D) Dieta baja en grasas y control ecográfico anual
E) Colecistectomía solo si los cálculos superan los 2 cm

PREGUNTA 71 1.06.2.010

71. **Hombre de 45 años consulta por dolor epigástrico intenso y vómitos biliosos. Al examen: FC 90/min, PA 140/90, escleras levemente ictéricas, abdomen blando y doloroso a la palpación epigástrica. Exámenes: escleras ictéricas leves, lipasa 190 U/L (VN < 60), bilirrubina total 3,1 mg/dL directa, ecografía con colédoco de 9 mm y microlitiasis. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Colangitis aguda
B) Pancreatitis aguda
C) Coledocolitiasis
D) Colecistitis aguda
E) Cólico biliar simple

PREGUNTA 72 1.06.2.010

72. **Paciente de 55 años con pancreatitis aguda biliar de 36 horas de evolución. Está hemodinámicamente estable, afebril, con dolor en disminución y tolera líquidos. Ecografía: colelitiasis, vía biliar de calibre normal, sin cálculos en el colédoco. ¿Cuál es la conducta más adecuada respecto de la vía biliar?**

A) CPRE de urgencia en las próximas 24 horas
B) Colecistectomía laparoscópica durante el mismo ingreso, una vez resuelto el episodio
C) Alta con colecistectomía programada en 6 a 8 semanas
D) Colangiorresonancia y luego CPRE si es positiva
E) Manejo médico indefinido, sin cirugía, por el riesgo quirúrgico

BLOQUE 5 ABDOMEN AGUDO Y URGENCIAS DIGESTIVAS

PREGUNTA 73 1.06.1.009

73. **Una paciente de 27 años presenta constipación de 3 años de evolución, con deposiciones caprinas, duras, que evacua una vez a la semana. Se realiza una radiografía de abdomen que muestra dolicocolon, con contenido en toda su extensión. ¿Cuál es el el tratamiento más adecuado?**

A) Laxantes osmóticos
B) Laxantes de contacto
C) Cambios de hábitos
D) Proquinéticos
E) Cirugía

PREGUNTA 74 1.06.1.014

74. Mujer de 74 años con epigastralgia de 3 semanas de evolución, sin irradiación, sin baja de peso. Antecedente de dispepsia tratada hace 10 años. AINES ocasionales. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

A) Endoscopía digestiva alta (EDA) para descartar lesión orgánica (criterios de alarma por edad >60 años)
B) Iniciar IBP y controlar en 4 semanas
C) Test de Helicobacter pylori no invasivo y tratar si positivo
D) Radiografía de abdomen
E) Ecografía abdominal

PREGUNTA 75 1.06.2.001

75. Un paciente presenta diarrea abundante, asociada a malestar general. En su tercer día de evolución, presenta dolor abdominal y distensión abdominal progresiva. Al examen Fsico se observa decaído, en malas condiciones generales, subfebril (37,6 °C), con abdomen distendido y doloroso a la palpación, sin signos peritoneales. Sus signos vitales muestran presión arterial 90/50 mmHg y frecuencia cardíaca 110 lpm. Se solicita radiograFa de abdomen, que revela dilatación de las asas del colon, alcanzando un diámetro de hasta 10 cm a la altura del ciego. ¿Cuál es el diagnós8co más probable?

A) Síndrome de Hirschsprung
B) Síndrome de Ogilvie
C) Obstrucción intes2nal
D) Coli2s isquémica
E) Megacolon tóxico

PREGUNTA 76 1.06.2.007

76. Un paciente de 61 años, con antecedente de haberse realizado una colonoscopía, hace un mes, la que estaba normal, consulta por una hemorragia digestiva baja abundante, con compromiso hemodinámico. Su frecuencia cardiaca es 120x' y su presión arterial, 90/60 mmHg. Se realiza endoscopía digestiva alta, que resulta normal y su hemograma muestra hematocrito de 19%, con hemoglobina: 6,3 g/dl. ¿Cuál es el examen de elección para continuar el estudio?

A) Ecografía abdominal
B) TAC de abdomen y pelvis
C) Cintigrafía con glóbulos rojos marcados
D) Colonoscopía
E) Angiografía mesentérica

PREGUNTA 77 1.06.2.001

77. Mujer de 24 años consulta por dolor que comenzó alrededor del ombligo y en 12 horas se localizó en la fosa ilíaca derecha, con náuseas y falta de apetito. Al examen tiene Blumberg positivo en la fosa ilíaca derecha. ¿Cuál es la primera conducta?

A) Apendicectomía laparoscópica inmediata
B) Test de embarazo y evaluación ginecológica
C) TAC de abdomen y pelvis con contraste
D) Iniciar antibióticos empíricos y observar 24 horas
E) Colonoscopía urgente

PREGUNTA 78 1.06.2.001

78. Mujer de 63 años con diverticulitis aguda. El TAC muestra abundante líquido y aire libre intraperitoneal, con signos de peritonitis fecal difusa. Está febril, taquicárdica e hipotensa. ¿Cuál es la conducta?

A) Antibióticos endovenosos y reevaluar en 48 horas
B) Drenaje percutáneo guiado por TAC
C) Cirugía de urgencia (operación de Hartmann)
D) Colonoscopía para localizar la perforación
E) Resección sigmoidea laparoscópica con anastomosis primaria diferida

PREGUNTA 79 1.06.2.001

79. Hombre de 70 años con antecedente de ateroesclerosis, tras un episodio de hipotensión por una hemorragia digestiva, presenta dolor cólico en el flanco izquierdo y elimina deposiciones con sangre roja. El abdomen está sensible en el flanco izquierdo, sin peritonismo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Embolia de la arteria mesentérica superior
B) Trombosis venosa mesentérica
C) Colitis isquémica
D) Diverticulitis aguda
E) Enfermedad de Crohn

PREGUNTA 80 1.06.2.001

80. Paciente de 72 años con fibrilación auricular presenta dolor abdominal súbito y muy intenso. El examen abdominal es prácticamente normal, sin defensa ni Blumberg. ¿Cuál es el examen diagnóstico de elección?

A) TAC de abdomen sin contraste
B) Ecografía abdominal
C) Angio-TAC (o angiografía) mesentérica
D) Radiografía de abdomen simple
E) Colonoscopía urgente

PREGUNTA 81 1.06.2.007

81. Al momento de la presentación de una hemorragia digestiva alta, ¿cuál de los siguientes parámetros determina mejor la gravedad del cuadro?

A) El hematocrito
B) La hemoglobina
C) La frecuencia cardíaca y la presión arterial
D) El volumen estimado de la hematemesis
E) El recuento de plaquetas

PREGUNTA 82 1.06.2.007

82. Paciente de 68 años con hemorragia digestiva baja masiva e inestabilidad hemodinámica. Se realiza una colonoscopía urgente que, por la abundante sangre, no logra identificar el sitio del sangrado. ¿Cuál es el siguiente paso?

A) Repetir la colonoscopía tras una nueva preparación
B) Endoscopía digestiva alta
C) TAC de abdomen sin contraste
D) Laparotomía exploradora inmediata
E) Alta con control ambulatorio en 48 horas

PREGUNTA 83 1.06.2.002

83. **Hombre de 45 años consulta por sensación de cuerpo extraño retroesternal tras comer un trozo grande de carne hace 6 horas. Tiene dolor retroesternal y no consigue tragar ni siquiera su saliva. ¿Cuál es la conducta?**

A) Observación por 24 horas
B) Radiografía de tórax y control en 12 horas
C) Endoscopía digestiva alta para desimpactar
D) Bebida carbonatada y enzimas proteolíticas para disolver la carne
E) TAC de tórax con contraste

PREGUNTA 84 1.06.2.002

84. **Niño de 5 años se tragó una moneda hace 3 horas. Está asintomático, sin sialorrea ni dificultad para tragar. La radiografía muestra la moneda en la cámara gástrica. ¿Cuál es la conducta más apropiada?**

A) Endoscopía digestiva alta urgente
B) Laparotomía para extraer la moneda
C) Observación con control radiológico cada 1–2 semanas
D) Administrar un laxante para acelerar el tránsito
E) Maniobra de Heimlich

PREGUNTA 85 1.06.2.005

85. **Preescolar de 4 años de una zona rural consulta por diarrea crónica de 2 meses, con abundante flatulencia y dolor abdominal tipo cólico. Dos hermanos tienen síntomas similares. Crece en un percentil bajo pero estable. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y su tratamiento?**

A) Diarrea crónica inespecífica; suspender los jugos
B) Enfermedad celíaca; dieta sin gluten
C) Giardiasis; tinidazol (o metronidazol)
D) Fibrosis quística; enzimas pancreáticas
E) Alergia a la proteína de leche de vaca; fórmula hidrolizada

PREGUNTA 86 1.06.2.005

86. **Lactante de 4 meses alimentado con fórmula presenta diarrea crónica con estrías de sangre, reflujo y episodios de exantema y sibilancias. El incremento ponderal está enlentecido. ¿Cuál es el estudio diagnóstico más apropiado?**

A) Test del sudor
B) Anticuerpos anti-transglutaminasa
C) Prueba terapéutica con fórmula extensamente hidrolizada por 2–4 semanas y posterior reintroducción
D) Parasitológico seriado de deposiciones
E) Endoscopía digestiva alta con biopsias

PREGUNTA 87 1.06.1.027

87. **Recién nacido de 4 semanas, previamente sano, con 5 días de vómitos explosivos posprandiales. Se muestra ávido por alimentarse. Al examen tiene signos de deshidratación; en el laboratorio destaca hipopotasemia y alcalosis metabólica. ¿Cuál es el examen diagnóstico más apropiado?**

A) pH-metría esofágica de 24 horas
B) Radiografía de abdomen simple
C) Ecografía abdominal
D) Endoscopía digestiva alta
E) TAC de abdomen

PREGUNTA 88 1.06.1.027

88. **Niño de 5 años con constipación crónica presenta dolor abdominal y manchado fecal en la ropa interior. Al examen se palpa una masa en el hipogastrio y, al tacto rectal, una gran masa fecal dura en la ampolla rectal. ¿Cuál es el tratamiento inicial?**

A) Dieta rica en fibra y aumento de la ingesta de agua
B) Polietilenglicol por vía oral para desimpactar
C) Extracción digital del fecaloma bajo sedación
D) Laxantes osmóticos en dosis de mantenimiento de forma indefinida
E) Derivación quirúrgica

PREGUNTA 89 1.01.1.001

89. **Recién nacido prematuro de 30 semanas, a los 6 días de vida, presenta residuo gástrico bilioso, distensión abdominal y deposiciones con sangre. La radiografía de abdomen muestra aire en el espesor de la pared intestinal. ¿Cuál es el diagnóstico?**

A) Atresia duodenal
B) Invaginación intestinal
C) Enterocolitis necrotizante
D) Enfermedad de Hirschsprung
E) Vólvulo del intestino medio

PREGUNTA 90 1.01.1.001

90. **Niño de 3 años, sano, consulta por un episodio de deposición con abundante sangre roja oscura, sin dolor abdominal. Está pálido y taquicárdico; el abdomen es blando, sin masas. La colonoscopía no muestra lesiones. ¿Cuál es el examen diagnóstico más apropiado?**

A) Repetir la colonoscopía con mejor preparación
B) Cintigrafía con pertecnetato de tecnecio-99m
C) Ecografía abdominal
D) Radiografía de abdomen simple
E) TAC de abdomen con contraste

SECCIÓN II · SOLUCIONARIO RAZONADO & MATRIZ PERFIL V3

Justificación médica de la clave correcta y análisis exhaustivo de cada distractor · Ancho Completo

CLAVES 1 A 90

BLOQUE 1 ESÓFAGO Y ESTÓMAGO · SOLUCIONARIO OFICIAL

PREGUNTA 1 **Respuesta: A** Cáncer de páncreas `1.06.1.002` Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Es una pregunta algo difícil. Tiene una ictericia obstructiva, con un patrón colestásico, lo que hace sospechar un cáncer que obstruye la vía biliar. La dilatación de la vesícula (signo de Courvoisier-Terrier) y la dilatación de la vía biliar extrahepática es característica de la obstrucción distal del colédoco, por lo que lo más probable es que sea un cáncer de cabeza de páncreas. El antecedente de fumar también orienta a esa causa. El diverVculo duodenal es mucho más infrecuente. El colangiocarcinoma generalmente está ubicado más alto en la vía biliar.

PREGUNTA 2 **Respuesta: A** Cáncer gástrico `1.06.1.004` Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Parece un cáncer gástrico. Siempre lo primero es confirmarlo con EDA y biopsia

PREGUNTA 3 **Respuesta: C** Diarrea crónica `1.06.1.011` Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Lo primero a descartar es el cáncer de colon (después la enfermedad celíaca).

PREGUNTA 4 **Respuesta: A** Disfagia `1.06.1.013` Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Por la disfagia lógica y por el antecedente de probable RGE (usa omeprazol). La acalasia produce disfagia ilógica. La edad sugiere también cáncer.

PREGUNTA 5 **Respuesta: E** Enfermedad diverticular complicada `1.06.1.016` Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Es una diverticulitis aguda post colonoscopía. Se estudia con TAC. Está absolutamente contraindicada la colonoscopía

PREGUNTA 6 **Respuesta: C** Reflujo gastroesofágico `1.06.1.027` Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo

Tiene reflujo clínico y por endoscopía. El tratamiento es IBP (ej. omeprazol) a permanencia. Que los síntomas hayan recurrido, solo hace que con mayor razón sea reflujo y se deban reiniciar los IBP.

PREGUNTA 7 **Respuesta: A** Úlcera péptica `1.06.1.030` Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo

Es una úlcera duodenal Activa. Aunque el test de ureasa esté negativo, si no usa AINES, se asume que es por H. pylori, porque el 90% de las úlceras duodenales son por esa causa y el test de ureasa no es un examen tan bueno. Es una pregunta difícil. En el caso de la úlcera gástrica, es más probable que pueda ser por otra causa (solo 70% es por HP) y se tendría que estudiar. También se estudiaría si hubiese algo más que hiciera sospechar otra enfermedad, como un Cröhn o un Zollinger Ellison.

PREGUNTA 8 **Respuesta: A** Afagia aguda `1.06.2.002` Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Pregunta oficial de examen EUNACOM (EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 50). Evalúa el manejo clínico de Afagia aguda según directrices MINSAL vigentes.

PREGUNTA 9 **Respuesta: A**

1.06.1.027 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico y Esófago de Barrett

Úlcera duodenal activa en un paciente que no usa AINE: se asume infección por Helicobacter pylori aunque el test de ureasa sea negativo (falso negativo frecuente si hay sangrado reciente o uso previo de IBP/antibióticos), porque el 90 % de las úlceras duodenales son por H. pylori. La conducta es la terapia erradicadora de primera línea (IBP + amoxicilina + claritromicina, 14 días), no solo supresión ácida. B y E tratan la úlcera pero no la causa. D corresponde a manejo de ERGE, no de úlcera. C retrasa el tratamiento sin cambiar la conducta.

PREGUNTA 10 **Respuesta: C**

1.06.1.027 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico y Esófago de Barrett

Falla de la erradicación de primera línea confirmada por test de control positivo: se indica un esquema de segunda línea que evite la claritromicina (terapia cuádruple con bismuto, o levofloxacino + amoxicilina + IBP). Repetir el mismo esquema (A) mantiene la resistencia a claritromicina. La endoscopía (B) sería obligatoria para el control de la úlcera gástrica en sí, pero la pregunta apunta a la conducta frente a la falla de erradicación. D y E no corrigen la infección persistente.

PREGUNTA 11 **Respuesta: B**

1.06.1.030 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Úlcera Péptica, Dispepsia Funcional y Helicobacter pylori

Toda úlcera duodenal se erradica aunque el test resulte negativo, porque el 90 % son por H. pylori y el test de ureasa tiene falsos negativos frecuentes (uso previo de IBP o antibióticos, sangrado reciente). Dar solo omeprazol (C) cicatriza pero no previene la recidiva. Repetir exámenes (D, E) retrasa el tratamiento sin cambiar la conducta.

PREGUNTA 12 **Respuesta: C**

1.06.1.030 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Úlcera Péptica, Dispepsia Funcional y Helicobacter pylori

Epigastralgia con endoscopía normal y sin signos de alarma es, por definición, dispepsia funcional (diagnóstico de exclusión que requiere endoscopía normal). El manejo es educación, manejo del estrés, moduladores del dolor y una prueba con IBP; se puede ofrecer erradicación de H. pylori si el test fuera positivo, lo que aquí no aplica. No corresponde tratar como úlcera (A) ni repetir estudios invasivos sin nuevas banderas rojas.

PREGUNTA 13 **Respuesta: C**

1.06.1.013 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Disfagia y Trastornos Motores del Esófago

Disfagia lógica (progresiva, de sólidos a líquidos) con baja de peso en un fumador es cáncer de esófago mientras no se demuestre lo contrario. El diagnóstico se hace con endoscopía digestiva alta y biopsia; el TAC y la endosonografía vienen después, para etapificar. La manometría y el esofagograma se reservan para la disfagia ilógica (sospecha de trastorno motor).

PREGUNTA 14 **Respuesta: C**

1.06.1.013 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Disfagia y Trastornos Motores del Esófago

Disfagia alta (la comida se queda "en la garganta", a nivel del esfínter esofágico superior) con halitosis marcada y regurgitación de alimento no digerido es el cuadro típico del divertículo de Zenker: el alimento se acumula en el saco diverticular y fermenta. El diagnóstico se confirma con esofagograma con bario. La halitosis es la clave que lo separa de la acalasia.

PREGUNTA 15 **Respuesta: C**

1.06.2.002 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Úlcera Perforada, Perforación Esofágica e Ingesta de Cáustico

En la ingesta de cáusticos la primera medida es la endoscopía digestiva alta precoz para graduar el daño de la mucosa y decidir si se observa, se deja en régimen cero con nutrición parenteral o se opera. El lavado gástrico, el carbón activado, los neutralizantes y provocar el vómito están contraindicados porque el daño es inmediato y todas esas maniobras lo agravan (reexposición del esófago al cáustico, perforación).

PREGUNTA 16 **Respuesta: B**

Úlcera Perforada, Perforación Esofágica e Ingesta de Cáustico

1.06.2.002 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Vómitos intensos seguidos de dolor torácico y enfisema subcutáneo (crepitación cervical), con fiebre y taquicardia, configuran la tríada del síndrome de Boerhaave (perforación esofágica espontánea). El Mallory-Weiss también sigue a los vómitos, pero se manifiesta con hematemesis y no produce enfisema ni sepsis. El examen inicial es la radiografía de tórax buscando neumomediastino; la endoscopía está contraindicada.

PREGUNTA 17 **Respuesta: B**

Cáncer de Esófago y Cáncer Gástrico

1.06.1.004 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Baja de peso con epigastralgia en un mayor de 40 años obliga a descartar cáncer gástrico, y el examen que confirma es la endoscopía digestiva alta con biopsias (además detecta la úlcera y permite tomar muestras para H. pylori). El TAC se usa después, para etapificar. Si el paciente además tuviera ictericia, la sospecha cambiaría a cáncer de páncreas y ahí sí el examen inicial sería el TAC.

PREGUNTA 18 **Respuesta: B**

Cáncer de Esófago y Cáncer Gástrico

1.06.1.004 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

El factor pronóstico principal del cáncer gástrico es la profundidad de invasión de la pared. Este es un cáncer incipiente (limitado a la mucosa), el de mejor pronóstico, y con esos criterios (lesión pequeña, bien diferenciada, sin úlcera, sin invasión submucosa) puede tratarse con resección endoscópica de la mucosa; en otros casos, gastrectomía. Observar (A) o solo erradicar H. pylori (C) deja el tumor sin tratar.

BLOQUE 2 INTESTINO Y COLON · SOLUCIONARIO OFICIAL

PREGUNTA 19 **Respuesta: A**

Trastornos digestivos funcionales

1.06.1.008 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo

El síndrome de intestino irritable SII) se caracteriza por dolor abdominal, que suele disminuir con la evacuación y cambios en la frecuencia y consistencia de las deposiciones. No Gene signos de alarma que hagan pensar en patología orgánica. Aunque su consGpación es funcional, el diagnóstico “consGpación funcional” se uGliza en caso en que no Gene dolor abdominal y, por tanto, no cumple con los criterios de SII.

PREGUNTA 20 **Respuesta: A** **Diarrea en inmunosuprimidos** 1.06.1.012 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Diarrea en inmunosuprimidos" (1.06.1.012), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 21 **Respuesta: B** **Enfermedad celiaca** 1.06.1.015 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo

Es una enfermedad celíaca clásica del adulto (diarrea y ferropenia).

PREGUNTA 22 **Respuesta: A**

Enfermedad diverticular no complicada

1.06.1.017 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Completo

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Enfermedad diverticular no complicada" (1.06.1.017), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Completo. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 23 **Respuesta: C** **Enfermedad inflamatoria intestinal** 1.06.1.018 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Enfermedad de Crohn: compromiso transmural + patrón en empedrado + úlceras aftosas con mucosa intercalada normal + fístula perianal + úlceras orales + localización que puede ser cualquier tramo del tubo digestivo. La CU no tiene fístulas ni compromiso ileal típico ni úlceras orales.

PREGUNTA 24 **Respuesta: A** **Intolerancia a la lactosa** 1.06.1.023 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Intolerancia a la lactosa" (1.06.1.023), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Completo y Seguimiento Completo. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 25 **Respuesta: A** **Parasitosis intestinales** 1.06.1.026 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Parasitosis intestinales" (1.06.1.026), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Completo y Seguimiento Completo. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 26 **Respuesta: B** **Síndrome de malabsorción** 1.06.1.028 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Pregunta discuGble. Tiene un síndrome de malabsorción intestinal, el que Gene muchas causas, sin que sea posible diferenciarlas con la sola clínica. Sin embargo, la presencia de esteatorrea franca y de empeoramiento de la clínica con la ingesta de grasas es lo clásico de la deficiencia de enzimas pancreáticas. La enfermedad celíaca es más frecuente y puede tener esteatorrea, pero suele ser más suGl, predominando la anemia, otros déficits nutricionales y molestias digestivas inespecíficas.

PREGUNTA 27 **Respuesta: D** **Tumores de colon** 1.06.1.029 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Es un cuadro sugerente de cáncer de colon (constipación y anemia en adulto mayor), que se estudia con colonoscopía.

PREGUNTA 28 **Respuesta: B** **Diarrea aguda** 1.06.2.005 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo

En mi opinión es una simple diarrea aguda.

PREGUNTA 29 **Respuesta: B**

Trastornos Digestivos Funcionales y Síndrome de Intestino Irritable

1.06.1.008 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Tiene múltiples signos de alarma: edad > 50 (límite), baja de peso involuntaria, cambio reciente del hábito intestinal, rectorragia y antecedente familiar de cáncer de colon. Eso descarta el manejo como trastorno funcional (A, C, E) y obliga a colonoscopía para descartar cáncer colorrectal. El test de sangre oculta (D) es una herramienta de tamizaje poblacional en personas asintomáticas, no sirve para estudiar a un paciente sintomático con banderas rojas.

PREGUNTA 30 **Respuesta: B**

Trastornos Digestivos Funcionales y Síndrome de Intestino Irritable

1.06.1.008 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Cumple criterios de Roma IV (dolor recurrente que alivia con la defecación y se asocia a cambio en la consistencia de las deposiciones) sin ningún signo de alarma y con exámenes básicos normales, incluyendo serología celíaca negativa. El diagnóstico de SII es clínico y positivo; corresponde iniciar tratamiento (educación, dieta, fármacos según síntoma) sin más estudios. Las alternativas A, C y D son estudios invasivos innecesarios en ausencia de banderas rojas.

PREGUNTA 31 **Respuesta: B**

1.06.2.005 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Diarrea Aguda, Diarrea Crónica y Constipación

Diarrea que aparece hasta un mes después del uso de antibióticos obliga a descartar Clostridioides difficile. El examen de elección actual es la PCR de toxina en deposiciones, más sensible que la detección de toxinas A y B. El tratamiento es metronidazol oral y, si falla, vancomicina oral; la respuesta se evalúa por la clínica, no repitiendo la PCR (puede quedar positiva por semanas).

PREGUNTA 32 **Respuesta: D**

1.06.2.005 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Diarrea Aguda, Diarrea Crónica y Constipación

La diarrea aguda del niño, por regla general, no lleva antibiótico. Solo se indica ante disentería con mal estado general, fiebre alta persistente por varios días, dolor abdominal intenso o aislamiento de Shigella o E. coli enteroinvasora. Este niño está en buen estado, sin disentería y con fiebre de pocas horas: el manejo es hidratación y observación.

PREGUNTA 33 **Respuesta: B**

1.06.1.015 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Síndrome de Malabsorción, Enfermedad Celíaca e Intolerancia a la Lactosa

La causa más frecuente de falta de respuesta en la celíaca es la transgresión dietética, pero en ese caso los anticuerpos suelen mantenerse elevados. Aquí los anticuerpos están negativos (lo que confirma buena adherencia) y aun así persiste la malabsorción: eso obliga a descartar un linfoma T asociado a enteropatía, complicación grave de la enfermedad celíaca que requiere imágenes y biopsias repetidas.

PREGUNTA 34 **Respuesta: C**

1.06.1.015 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Síndrome de Malabsorción, Enfermedad Celíaca e Intolerancia a la Lactosa

Ictericia, daño hepático, cataratas y retraso del desarrollo en el recién nacido configuran una galactosemia. El tratamiento es eliminar toda la galactosa: están contraindicadas la lactancia materna y las fórmulas de origen animal. La fórmula sin lactosa no sirve, porque aporta galactosa (la lactasa añadida hidroliza la lactosa en glucosa y galactosa). Se usa fórmula de soya u otra de origen vegetal.

PREGUNTA 35 **Respuesta: B**

1.06.1.018 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Enfermedad Inflamatoria Intestinal: Colitis Ulcerosa y Enfermedad de Crohn

La colonoscopía define el caso: inflamación en parches (zonas de mucosa indemne) y respeto del recto. Cualquiera de esas dos características, por sí sola, descarta la colitis ulcerosa —que es continua y siempre rectal— y establece el diagnóstico de enfermedad de Crohn.

PREGUNTA 36 **Respuesta: D**

1.06.1.018 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Enfermedad Inflamatoria Intestinal: Colitis Ulcerosa y Enfermedad de Crohn

La colitis ulcerosa de larga data multiplica el riesgo de cáncer colorrectal, sobre todo rectal, y todo sangrado digestivo bajo nuevo en un adulto exige colonoscopía completa: la rectosigmoidoscopía no explora el colon proximal y dejaría lesiones sin ver. No se asume un brote ni se inician corticoides antes de descartar neoplasia.

BLOQUE 3 HÍGADO · SOLUCIONARIO OFICIAL

PREGUNTA 37 **Respuesta: E** **Ascitis**

1.06.1.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Parece una carcinomatosis tanto por la clínica de cáncer (fumador, baja de peso, cuadro progresivo) como por el análisis con un exudado mononuclear y ADA baja (se interpreta similar al estudio de líquido pleural). No es una PBE (peritoniGs bacteriana espontánea), ya que requiere más de 250 PMN y predominio PMN.

PREGUNTA 38 **Respuesta: B** Colestasia 1.06.1.007 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Es una CBP (cirrosis biliar primaria) clásica: mujer de edad media, con colestasia crónica, con elevación prominente de las fosfatasas alcalinas; aunque falta la clínica de astenia, que es el síntoma más frecuente. No tiene factores de riesgo para la esteatosis hepática (hígado graso) y, además, suele cursar con hepatitis y no colestasia. La colestasia por compresión externa, suele ser por cáncer y viene con mucha ictericia (no es el caso). La colangitis esclerosante primaria puede tener un cuadro similar, pero en lugar de ser una mujer de edad media, suele ser en hombres, con antecedente de colitis ulcerosa.

PREGUNTA 39 **Respuesta: A**

Hepatitis aguda A no complicada 1.06.1.019 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo

Cuadro clásico

PREGUNTA 40 **Respuesta: D**

Hepatitis agudas B, C, por otros virus, por drogas y tóxicas 1.06.1.020 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Tiene una hepatitis, que, por descarte, es farmacológica (por la isotretinoína). No es VHA, porque la IgM está negativa. No es VHB porque el antígeno de superficie está negativo (no aporta mayor información los anticuerpos totales anticore). No es VHC, porque los anticuerpos totales anti VHC está negativos.

PREGUNTA 41 **Respuesta: E** Hepatitis crónica 1.06.1.021 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Tiene una hepatitis crónica. El antecedente de transfusión orienta a hepatitis C, pero la verdad es que debe estudiarse con más exámenes, como por ejemplo el Ag VHBs, por lo que es una mala pregunta. Antes del año 2000, los casos de hepatitis B eran casi cero, por lo que no puede ser.

PREGUNTA 42 **Respuesta: A** Insuficiencia hepática crónica 1.06.1.022 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Insuficiencia hepática crónica" (1.06.1.022), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 43 **Respuesta: B** Masa hepática 1.06.1.024 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Es un adenoma hepático, por el aspecto, el tamaño (sólido, hipoecogénico, aspecto homogéneo) y por la alfafetoproteína no elevada. La cirrosis aumenta el riesgo de adenomas y hepatocarcinomas. Metástasis: se ven hipoecogénicas, sólidas y múltiples. Hepatocarcinoma: se ve heterogéneo y más grande, sólido y además eleva la AFP. Quiste: se ve anecogénico, con refuerzo posterior. Hemangioma: se ve hiperecogénico, homogéneo.

PREGUNTA 44 **Respuesta: E** Encefalopatía hepática 1.06.2.006 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La encefalopatía hepática se trata con lactulosa. Sin embargo lo más importante siempre es descartar patología descompensante (infecciones). El amonio sirve para hacer el diagnóstico: se eleva la amonemia en la encefalopatía hepática

PREGUNTA 45 **Respuesta: B** Hepatitis aguda A complicada 1.06.2.008 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Hepatitis aguda grave: El cuadro clínico es compatible con una hepatitis aguda, confirmada por las pruebas hepáticas que muestran una elevación significativa de las transaminasas. La IgM positiva para el virus de la hepatitis A confirma la etiología. La gravedad del cuadro radica en la disminución de la protrombinemia, lo que requiere manejo hospitalario. Aunque aún no cumple con los criterios de hepatitis fulminante (no hay compromiso de la conciencia), la caída de la protrombinemia aumenta el riesgo de evolucionar hacia ella.

PREGUNTA 46 **Respuesta: A** **Insuficiencia hepática aguda** 1.06.2.009 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Insuficiencia hepática aguda" como urgencia clínica (1.06.2.009), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

PREGUNTA 47 **Respuesta: D**

Peritonitis bacteriana espontánea del cirrótico 1.06.2.011 Dx: Sospecha · Tx: Completo · Seg: Derivar

Es una PBE. También hay que dar albúmina (1,5 g/Kg de peso el primer día y 1,0 g/Kg de peso al tercer día), pero los ATB son lo más importante. Se da Cefotaximo.

PREGUNTA 48 **Respuesta: A** **Síndrome hepatorrenal** 1.06.2.012 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Síndrome hepatorrenal" como urgencia clínica (1.06.2.012), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

PREGUNTA 49 **Respuesta: C**

Ictericia y Colestasia: Enfrentamiento Diagnóstico 1.06.1.007 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Hiperbilirrubinemia indirecta aislada, con el resto de las pruebas hepáticas y el hemograma normales, en un joven asintomático: es un síndrome de Gilbert, un trastorno hereditario benigno de la conjugación de la bilirrubina que afecta al 5–10 % de la población y suele hacerse evidente con el ayuno o las infecciones. No requiere estudio adicional ni tratamiento.

PREGUNTA 50 **Respuesta: B**

Ictericia y Colestasia: Enfrentamiento Diagnóstico 1.06.1.007 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

El patrón es colestásico con dolor y sin fiebre: coledocolitiasis. La ecografía muestra la vía biliar dilatada pero no ve el cálculo, así que el siguiente paso es la colangiorresonancia para confirmarlo antes de someter a la paciente a una CPRE (que es invasiva y tiene riesgo de pancreatitis). Se va directo a CPRE solo si hay colangitis o si la ecografía ya vio el cálculo en el colédoco.

PREGUNTA 51 **Respuesta: A**

Hepatitis Aguda y Crónica 1.06.1.019 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

El AgHBs negativo descarta infección activa y los anti-HBs positivos indican inmunidad. Como no se informan anti-HBc, el patrón "anti-HBs aislado" corresponde a inmunidad por vacuna (una infección resuelta también tendría anti-HBc IgG positivos). En ningún caso hay enfermedad activa ni período de ventana.

PREGUNTA 52 **Respuesta: B**

Hepatitis Aguda y Crónica 1.06.1.019 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Es una hepatitis A aguda (IgM anti-VHA positiva) con transaminasas muy elevadas y, sobre todo, protrombinemia de 52 %. Aún no hay encefalopatía, por lo que no cumple criterios de hepatitis fulminante, pero la caída del tiempo de protrombina es el marcador de gravedad y de riesgo de progresión: obliga a hospitalizar para vigilancia. El manejo ambulatorio se reserva para la hepatitis A no complicada con protrombina normal.

PREGUNTA 53 **Respuesta: D**

1.06.1.019 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Hepatitis Aguda y Crónica

La IgM anti-VHA negativa descarta hepatitis A aguda (la IgG solo marca contacto previo). El AgHBs negativo descarta infección B activa; los anti-HBc totales positivos sin AgHBs indican solo exposición pasada. Por descarte, y por la relación temporal con un fármaco hepatotóxico conocido (isotretinoína), el diagnóstico es hepatitis por fármacos: la conducta es suspender el fármaco de inmediato.

PREGUNTA 54 **Respuesta: B**

1.06.1.005 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Daño Hepático Crónico e Hipertensión Portal

La profilaxis primaria de la hemorragia variceal (paciente que nunca ha sangrado) es el betabloqueo no selectivo, titulado para reducir la frecuencia cardíaca. La ligadura endoscópica se añade en la profilaxis secundaria (tras un primer sangrado) o se usa sola cuando el betabloqueo está contraindicado (asma, EPOC grave, intolerancia).

BLOQUE 4 VÍA BILIAR Y PÁNCREAS · SOLUCIONARIO OFICIAL

PREGUNTA 55 **Respuesta: B** **Cáncer de vesícula y vías biliares** 1.06.1.003 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Las pruebas hepáticas muestras una colestasia clara y la clínica también. La colestasia silente (sin dolor) o con escaso dolor suele ser por cáncer (cualquier a de los de las opciones). De todos modos, orienta a cáncer de vesícula el hecho de que sea mujer y, además, el antecedente de cólicos biliares (ya que la colelitiasis es el factor de riesgo más importante). El cáncer de cabeza de páncreas suele preguntarse en diabéticos o fumadores y suele mostrarse la dilatación del colédoco en la ecografía.

PREGUNTA 56 **Respuesta: D** **Cáncer de vesícula y vías biliares** 1.06.1.003 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Sospecha de Cáncer de Vía Biliar: La sospecha clínica en este paciente es de un cáncer que obstruye la vía biliar, considerando su edad y la presencia de ictericia sin dolor. El antecedente de colecistectomía previa hace poco probable un cáncer de vesícula biliar, pero aún puede tener uno de vía biliar o colangiocarcinoma.

PREGUNTA 57 **Respuesta: A** **Cáncer de vesícula y vías biliares** 1.06.1.003 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Tiene clínica de un trastorno digestivo funcional (ej. Síndrome de intestino irritable) y los hallazgos en la ecografía no muestran sino un pólipo de características benignas (son malignos y hay que sacarlos si: miden más de 1 cm, tienen cálculos asociados, tienes aspecto invasor o heterogéneo). La vía biliar normal es hasta 7 mm.

PREGUNTA 58 **Respuesta: A** **Colelitiasis** 1.06.1.006 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Es una imagen clásica de cálculos biliares, con la sombra acústica característica de los cálculos. La clínica son cólicos biliares.

PREGUNTA 59 **Respuesta: A** **Colelitiasis** 1.06.1.006 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Probablemente tiene una colelitiasis (clínica de cólico biliar). Se estudia con Eco. En agudo sí debió haberse pedido la amilasa/lipasa para descartar pancreatitis, pero ahora solo hay que descartar la colelitiasis.

PREGUNTA 60 **Respuesta: A** **Colelitiasis** 1.06.1.006 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Caso clínico oficial EUNACOM para Colelitiasis.

PREGUNTA 61 **Respuesta: A** **Colelitiasis** 1.06.1.006 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Coledocolitiasis residual sintomática: primera línea = CPRE con esfinterotomía endoscópica y extracción del cálculo. Evita reoperación y tiene alta tasa de éxito (>90%).

PREGUNTA 62 **Respuesta: B** **Colelitiasis** 1.06.1.006 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Parece una coledocolitiasis. Se debe estudiar inicialmente con una colangioresonancia y luego (si la colangioRMN ve los cálculos), se procede a la CPRE (también se hace la CPRE si tiene clínica de colangitis o si la eco ve los cálculos en el colédoco).

PREGUNTA 63 **Respuesta: A** **Colelitiasis** 1.06.1.006 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Dado que hay dilatación del colédoco (mayor a 7 mm), lo más probable es que sea una colédocolitiasis. Las colestasias farmacológicas suelen producirse a nivel hepático y no a nivel del colédoco.

PREGUNTA 64 **Respuesta: A** **Diarrea asociada a antibióticos** 1.06.1.010 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo

Diarrea con sangre + fiebre en paciente hospitalizada reciente + puérpera (exposición a antibióticos perinatales) = infección por C. difficile. Diagnóstico: toxina A/B en deposiciones. Tratamiento: vancomicina oral.

PREGUNTA 65 **Respuesta: C** **Pancreatitis crónica** 1.06.1.025 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Pancreatitis crónica: dolor epigástrico irradiado a la espalda + ingesta de alcohol crónico + posición antiálgica en flexión + baja de peso + CALCIFICACIONES pancreáticas en radiografía = tríada diagnóstica. El dolor mejora en reposo y empeora con la ingesta.

PREGUNTA 66 **Respuesta: E** **Colangitis** 1.06.2.003 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Tiene una colangitis aguda clásica. Se trata con drenaje endoscópico de la vía biliar (además, se da SF ev, ATB ev y, en segunda instancia, se realiza una colecistectomía laparoscópica).

PREGUNTA 67 **Respuesta: A** **Colecistitis aguda** 1.06.2.004 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Colecistitis aguda" como urgencia clínica (1.06.2.004), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

PREGUNTA 68 **Respuesta: C** **Pancreatitis aguda** 1.06.2.010 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Es una pancreatitis clásica. SEGUNDA PARTE

PREGUNTA 69 **Respuesta: B**

Colelitiasis, Colecistitis, Coledocolitiasis y Colangitis 1.06.1.006 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Dolor + ictericia + fiebre (tríada de Charcot) con hipotensión y compromiso de conciencia constituyen la péntada de Reynolds: una colangitis aguda grave. La prioridad es la reanimación con volumen, los antibióticos de amplio espectro y, sobre todo, el drenaje biliar urgente mediante CPRE. La colecistectomía se difiere hasta que el paciente se estabilice.

PREGUNTA 70 **Respuesta: C**

Colelitiasis, Colecistitis, Coledocolitiasis y Colangitis 1.06.1.006 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

En Chile, que tiene la incidencia de cáncer de vesícula más alta del mundo, la conducta ante una colelitiasis —aunque sea asintomática— es la colecistectomía laparoscópica electiva. El GES garantiza esta cirugía preventiva en el grupo de 35 a 49 años. La disolución con ursodesoxicólico y la observación no protegen del cáncer.

PREGUNTA 71 **Respuesta: B** Pancreatitis Aguda 1.06.2.010 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La lipasa está sobre 3 veces el límite superior (> 180 U/L) junto con dolor típico: cumple criterios de pancreatitis aguda, y aunque coexista una coledocolitiasis (colédoco dilatado, patrón colestásico), "manda" la pancreatitis por ser la condición más grave y la que define la conducta. No hay fiebre ni compromiso hemodinámico que hagan pensar en colangitis (A). El colédoco dilatado y la ictericia descartan un cólico biliar simple (E) y la colecistitis (D) cursaría con Murphy y sin esta magnitud de ictericia.

PREGUNTA 72 **Respuesta: B** Pancreatitis Aguda 1.06.2.010 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

En la pancreatitis biliar leve que ya resolvió, la colecistectomía laparoscópica debe realizarse en el mismo ingreso, porque diferirla se asocia a alta tasa de recurrencia de pancreatitis, colecistitis o colangitis en las semanas siguientes. La CPRE urgente (A) solo se indica si hay colangitis u obstrucción biliar persistente, lo que aquí no ocurre (afebril, vía biliar normal). La colangiorresonancia (D) no aporta porque la probabilidad de coledocolitiasis es baja. Diferir la cirugía (C) o no operar (E) deja al paciente expuesto a un nuevo evento.

BLOQUE 5 ABDOMEN AGUDO Y URGENCIAS DIGESTIVAS · SOLUCIONARIO OFICIAL

PREGUNTA 73 **Respuesta: C** Constipación 1.06.1.009 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo

El dolicolon (colon largo) no ha demostrado asociarse efectivamente a constipación. La conducta es tratar la constipación en un paciente joven, es decir, mejorar los hábitos. También es aconsejable aumentar la fibra en la dieta. Los laxantes se desaconsejan, ya que producen dependencia y solo se usan en problemas transitorios o cuando fallan las medidas generales.

PREGUNTA 74 **Respuesta: A** Dispepsia 1.06.1.014 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo

Dispepsia en >60 años = criterio de alarma por edad → EDA obligatoria para descartar cáncer gástrico, úlcera péptica u otras lesiones orgánicas. No se puede tratar empíricamente en este grupo etario.

PREGUNTA 75 **Respuesta: E** Abdomen agudo 1.06.2.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Es un megacolon tóxico. El diagnóstico se confirma por la tríada de: 1) antecedente de coliGs (diarrea), 2) dilatación colónica >6 cm en radiografía y 3) signos de toxicidad sistémica (hipotensión, taquicardia y fiebre). Es una emergencia médica que requiere descompresión y soporte hemodinámico agresivo.

PREGUNTA 76 **Respuesta: D** Hemorragia digestiva alta y baja 1.06.2.007 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La colonoscopía es el examen de elección para enfrentar la HDB. La EDA se hizo, porque tenía hemodinamia inestable (siempre se debe hacer en ese caso). No importa que hace un mes tuviese una colonoscopía normal. Si no localiza, se procede a la cintigrafía con GR marcados o a la angiografía mesentérica.

PREGUNTA 77 **Respuesta: B**

Abdomen Agudo: Apendicitis y Diverticulitis

1.06.2.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

En toda mujer en edad fértil con dolor en la fosa ilíaca derecha y sospecha de apendicitis, lo primero es descartar patología ginecológica y, sobre todo, un embarazo ectópico: se solicita test de embarazo y evaluación ginecológica (con ecografía). Recién después se confirma la apendicitis (clínica + ecografía) y se lleva a pabellón. Operar sin este paso puede pasar por alto un ectópico roto.

PREGUNTA 78 **Respuesta: C**

Abdomen Agudo: Apendicitis y Diverticulitis

1.06.2.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Aire y líquido libre con peritonitis fecal corresponde a un Hinchey IV (perforación libre con contaminación fecal), que junto con el Hinchey III (peritonitis purulenta) es indicación de cirugía de urgencia: resección del sigmoides con colostomía terminal y cierre del muñón rectal (operación de Hartmann), reconstruyendo el tránsito meses después. El manejo médico o percutáneo solo sirve en los abscesos (Hinchey I–II).

PREGUNTA 79 **Respuesta: C**

Isquemia Mesentérica y Abdomen Agudo de Origen Vascular

1.06.2.001 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Dolor en el hemiabdomen izquierdo con hematoquecia en un adulto mayor con ateroesclerosis, precipitado por un episodio de hipotensión (bajo flujo), es característico de la colitis isquémica, que afecta las zonas frontera de irrigación del colon (ángulo esplénico, rectosigmoides). Suele ser transitoria y responde al manejo médico. La embolia mesentérica da dolor mucho más intenso y difuso, con disociación clínica, en el contexto de fibrilación auricular.

PREGUNTA 80 **Respuesta: C**

Isquemia Mesentérica y Abdomen Agudo de Origen Vascular

1.06.2.001 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La sospecha es una embolia mesentérica (fibrilación auricular + dolor súbito intenso + disociación clínica). El examen de elección es el angio-TAC, que muestra el defecto de llene en la arteria mesentérica superior; la angiografía formal se usa cuando además se planea un tratamiento endovascular. El TAC sin contraste y la radiografía simple no muestran el émbolo y hacen perder tiempo valioso.

PREGUNTA 81 **Respuesta: C**

Hemorragia Digestiva Alta y Baja

1.06.2.007 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

En el sangrado agudo se pierde sangre completa (plasma y glóbulos rojos en proporción), por lo que el hematocrito inicial suele ser normal y solo cae horas después, cuando el líquido intersticial diluye la masa eritrocitaria. La gravedad al momento de la presentación la marca el compromiso hemodinámico: taquicardia (lo más precoz), ortostatismo y, finalmente, hipotensión. Nunca se debe esperar el hematocrito para iniciar la reanimación.

PREGUNTA 82 **Respuesta: B**

Hemorragia Digestiva Alta y Baja

1.06.2.007 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Cerca del 10 % de las hemorragias que se manifiestan como hematoquecia tienen en realidad un origen alto (HDA masiva con tránsito acelerado). Por eso, si la colonoscopía urgente no localiza el sangrado en un paciente inestable, el siguiente paso es la endoscopía digestiva alta. Si tampoco la localiza, se continúa con angio-TAC/angiografía (que puede ser terapéutica) y, en último término, cirugía.

PREGUNTA 83 **Respuesta: C** **Cuerpo Extraño Digestivo** 1.06.2.002 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La comida impactada en el esófago con dolor e incapacidad de tragar la saliva (obstrucción esofágica completa) requiere endoscopía digestiva alta para retirarla, sin demora, por el riesgo de aspiración y de perforación. Solo se puede observar hasta 24 horas cuando el paciente está sin dolor y tolera líquidos. Tras resolver el episodio conviene estudiar el esófago (esofagitis eosinofílica, estenosis, anillo de Schatzki).

PREGUNTA 84 **Respuesta: C** **Cuerpo Extraño Digestivo** 1.06.2.002 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Una moneda (objeto romo, no cáustico, no magnético) que ya pasó el esófago y está en el estómago, en un niño asintomático, se maneja con observación y control radiológico cada 1–2 semanas: la gran mayoría se elimina espontáneamente sin complicaciones. La endoscopía se reservaría si el objeto no progresa en 3–4 semanas o si aparecen síntomas. Solo las pilas, los imanes múltiples y los objetos afilados o largos se retiran aunque estén en el estómago.

PREGUNTA 85 **Respuesta: C**

Diarrea Aguda y Crónica en el Niño

1.06.2.005 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Diarrea crónica con flatulencia y dolor cólico en un preescolar de zona rural, con varios convivientes afectados, es muy sugerente de giardiasis. Se confirma con parasitológico seriado (3 muestras en días distintos) y se trata con tinidazol o metronidazol. La giardiasis puede producir un síndrome de malabsorción idéntico al de la celíaca, por lo que siempre debe descartarse antes de ese diagnóstico.

PREGUNTA 86 **Respuesta: C**

1.06.2.005 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Diarrea Aguda y Crónica en el Niño

Un lactante con síntomas gastrointestinales (diarrea con sangre, reflujo, mal incremento) y alérgicos (exantema, sibilancias) sugiere alergia a la proteína de leche de vaca. El diagnóstico se hace con prueba terapéutica: se cambia a fórmula extensamente hidrolizada (o de aminoácidos) por 2–4 semanas y, si mejora, se reintroduce la proteína de leche de vaca; la reaparición de los síntomas confirma el diagnóstico. No existe un test sanguíneo validado para esta condición.

PREGUNTA 87 **Respuesta: C**

1.06.1.027 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Reflujo del Lactante, Dolor Abdominal Crónico y Constipación en el Niño

Vómitos explosivos y proyectivos que comienzan entre la 2.ª y la 6.ª semana de vida, en un lactante hambriento, con deshidratación y alcalosis metabólica hipoclorémica e hipopotasémica (por la pérdida de ácido clorhídrico en los vómitos), son característicos de la estenosis hipertrófica del píloro. El diagnóstico se confirma con ecografía abdominal, que muestra el músculo pilórico engrosado. El tratamiento es la corrección hidroelectrolítica seguida de la pilorotomía de Ramstedt.

PREGUNTA 88 **Respuesta: B**

1.06.1.027 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Reflujo del Lactante, Dolor Abdominal Crónico y Constipación en el Niño

Antes de cualquier medida de mantenimiento hay que desimpactar el fecaloma, y el tratamiento de elección para la desimpactación es el polietilenglicol por vía oral (alternativa: enema). El manchado fecal es pseudoincontinencia por rebosamiento alrededor del fecaloma. La dieta y los laxantes de mantenimiento (fase 2) recién se inician una vez vaciado el recto; la extracción digital se reserva para casos excepcionales.

PREGUNTA 89 **Respuesta: C**

1.01.1.001 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Cirugía Pediátrica Digestiva: Urgencias y Malformaciones

Un recién nacido prematuro con la tríada de retención gástrica, distensión abdominal y hematoquecia, junto con neumatosis intestinal (aire en la pared del intestino) en la radiografía, tiene una enterocolitis necrotizante. El manejo inicial es régimen cero, nutrición parenteral total, sonda para descompresión y antibióticos endovenosos; la cirugía se indica ante neumoperitoneo (perforación) o deterioro pese al tratamiento médico.

PREGUNTA 90 **Respuesta: B**

1.01.1.001 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Cirugía Pediátrica Digestiva: Urgencias y Malformaciones

Una hemorragia digestiva baja abundante e indolora en un niño pequeño, con colonoscopía normal, orienta a un divertículo de Meckel: la mucosa gástrica ectópica que contiene secreta ácido y ulcera el íleon adyacente. El examen de elección es la cintigrafía con pertecnetato de Tc-99m, que es captado por esa mucosa gástrica ectópica. La colonoscopía no alcanza el íleon donde se ubica el divertículo.
